

Faculté de Médecine Oran
Annexe Tiaret



@CUREOLOGY
Contactez-nous



ANAPATH IMMUNO

3^{ème} Année Médecine

QCM Classés par cours



2025- 2026





Welcome to CUREOLOGY

Méthode de CURE :

I - Analysez chaque question attentivement afin de distinguer la bonne réponse des mauvaises.

I - Pathologie Cellulaire & Tissulaire

Pathologie Cellulaire & Tissulaire

1. Introduction à l'ACP

1. Concernant les prélèvements cytologiques

- A- Ils permettent de faire un diagnostic de certitude.
- B- Ils constituent l'examen de choix pour le dépistage du cancer du col utérin.
- C- Le prélèvement peut être fixé à l'air.
- D- Le fixateur de choix est le formol.
- E- Peut se faire en utilisant une aiguille.

Source: Q51P2022 & Q65 P2021

II - À la fin de chaque cours, vous trouverez les Qst à compléter dans des cases vides, comme une simulation d'examen, pour votre première tentative.

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☒	☐
Q2	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☒	☐	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☒

III - À la fin de chaque chapitre, vous aurez accès aux corrigés types officiels, vous permettant de vérifier et consolider vos réponses.

RÉPONSES

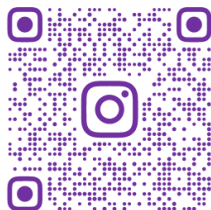
1. Introduction à l'ACP

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☒	☐	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☐

@cureology

@cureology_



CUREOLOGY_



@CUREOLOGY

Nos Caractéristiques :

Classement par cours :

- Les questions sont regroupées par cours, conformément au programme officiel, pour un apprentissage clair et progressif.

Organisation logique :

- Les leçons suivent un ordre cohérent, facilitant la compréhension et la révision méthodique.

Source complète :

- Chaque question indique sa source exacte, avec le numéro correspondant dans le document original, garantissant la fiabilité du contenu.

Navigation interactive :

- Un simple clic sur le numéro de page dans l'index vous conduit directement à la leçon concernée, rendant la consultation rapide et fluide.

Lien de retour :

- En bas de chaque page, un lien vous ramène à l'index, éliminant tout besoin de scroll manuel et les allers-retours inutiles.

Simulation d'examen :

- La présentation reprend la structure d'un examen officiel : des cases vides pour vos réponses et les solutions à la fin du chapitre.

Apprentissage actif :

- Les réponses sont séparées des questions afin de stimuler la réflexion et la mémorisation.

Design unique :

- Un style visuel moderne, clair et exclusif, conçu pour une expérience de lecture efficace.

Accès Gratuit illimité, valeur maximale :

- Tout le contenu est mis à votre disposition Gratuitement 100% – sans aucune restriction

Usage personnel uniquement :

- Réutilisation commerciale du contenu sans autorisation est interdite

SOMMAIRE

I - Chapitre 01 : Pathologie CELLULAIRE & TISSULAIRE	1
1. Introduction à l'ACP	1
2. Lésions Cellulaires & Tissulaires	1
3. Réponses Adaptatives (Cellule & Tissu)	2
4. Pathologies de La MEC	4
5. Athérosclérose	5
6. Pathologie Vasculaire & Troubles Circulatoires	6
7. Troubles des Métabolismes	7
RÉPONSES - Chapitre 01	7
II - Chapitre 02 : INFLAMMATION	8
1. Processus Inflammatoire	8
2. Réparation & Cicatrisation	9
3. Formes de l'Inflammation	11
4. Aspects Anato-mo-Cytopathologiques des infections	12
5. Immunopathologie	13
RÉPONSES - Chapitre 02	13
III - Chapitre 03 : CANCÉROLOGIE	15
1. Tumeurs & Processus Tumoral	15
2. Classifications & Diagnostic Tumoral	16
3. Carcinogénèse	17
4. Étiologies du cancer	17
5. Progression Tumoral	17
6. Tumeurs Épithéliales Glandulaires	18
7. Tumeurs Malpighienne & Urothéliales	18
8. Tumeurs Mésenchymateuse	20
9. Lymphomes	21
10. Tumeurs Nerveuses et Mélanocytaires	21
11. Tumeurs Embryonnaires	22
RÉPONSES - Chapitre 03	23
IV - Cas Cliniques	24
1. Cas Cliniques	24
RÉPONSES – Cas Cliniques	29

Pathologie Cellulaire & Tissulaire

1. Introduction à l'ACP

1. Concernant les prélèvements cytologiques

- A- Ils permettent de faire un diagnostic de certitude.
- B- Ils constituent l'examen de choix pour le dépistage du cancer du col utérin.
- C- Le prélèvement peut être fixé à l'air.
- D- Le fixateur de choix est le formol.
- E- Peut se faire en utilisant une aiguille.

Source: Q51 P2022 & Q65 P2021

En 2021, la même question avec les mêmes propositions, mais la proposition E a été corrigée une fois comme un réponse juste et d'autre fois fausse.

2. L'examen extemporané

- A- C'est un examen réalisé en peropératoire.
- B- Permet de s'assurer de l'exérèse de la totalité de la lésion avec des marges suffisantes.
- C- Le prélèvement envoyé doit être fixé au formol.
- D- Les coupes sont réalisées sur prélèvement de tissu frais congelé à -30°C.
- E- Permet de guider l'acte chirurgical.

Source: Q52 P2022 & Q66 P2021

3. L'étude cytologique :

- A- Est souvent complétée par un examen histologique.
- B- Constitue l'examen de choix pour le dépistage des cancers du col.
- C- Permet de faire une immuno-cytochimie.
- D- Son fixateur de choix est le formol.
- E- La coloration de choix est le trichrome de Masson.

Source: Q5 P2019

4. Concernant les prélèvements cytologiques :

- A- Ils permettent de faire un diagnostic de certitude.
- B- Ils constituent l'examen de choix pour le dépistage du cancer du col utérin.
- C- Ils permettent de faire une Immuno-cytochimie.
- D- Le fixateur de choix est le formol.
- E- La coloration au trichrome de Masson colore les cellules en bleu.

Source: Q5 P2019 RATTRAPAGE

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

2. Lésions Cellulaires & Tissulaires

1. La nécrose cellulaire :

- A- Est toujours d'origine ischémique.
- B- Correspond à une lyse cellulaire.
- C- Est toujours accompagnée d'une réaction inflammatoire.
- D- Est physiologique au cours de l'embryogenèse.
- E- Est une étape obligatoire du vieillissement cellulaire.

Source: Q58 P2022

2. Concernant la nécrose cellulaire :

- A- Il s'agit d'une lésion irréversible.
- B- La nécrose est toujours d'origine infectieuse.
- C- Elle respecte toujours le noyau.
- D- Les mitochondries sont préservées.
- E- La nécrose est synonyme d'apoptose.

Source: Q59 P2022

3. La nécrose est l'ensemble :

- A- Des modifications nucléaires.
- B- Des modifications métaboliques.
- C- Des modifications biochimiques.
- D- Des modifications cytoplasmiques.
- E- Des modifications vasculaires.

Source: Q60 P2022

4. Concernant la nécrose et l'apoptose :

- A- Deux modes de mort cellulaire possèdent les mêmes caractéristiques morphologiques.
- B- L'Apoptose est une mort cellulaire programmée.
- C- Les deux sont des phénomènes physiologiques actifs.
- D- La nécrose survient à un stade précis de la maturation terminale d'une cellule.
- E- L'apoptose joue un rôle essentiel dans le renouvellement des cellules à durée de vie courte.

Source: Q72 P2021

5. La Nécrose cellulaire:

- A- Est un phénomène passif, et réversible.
- B- Est essentiellement cytoplasmique, puis nucléaire suite à une agression de la cellule.
- C- Elle résulte de l'autolyse enzymatique de l'ensemble de la cellule.
- D- Les aspects de la nécrose tissulaire sont liés à ceux de la nécrose cellulaire.
- E- Elle concerne des cellules isolées et non pas des groupes de cellules comme l'apoptose.

Source: Q73 P2021

6. Concernant l'aspect histologique de la Nécrose on peut noter une :

- A- Pycnose.
- B- Caryolyse.
- C- Caryorrhexis.
- D- Cytoplasme vacuolisé, hydropique ou surchargé en lipides.
- E- Hyperéosinophilie cytoplasmique.

Source: Q74 P2021

7. La nécrose gangréneuse :

- A- C'est une nécrose de liquéfaction (nécrose suppurée).
- B- C'est une nécrose de coagulation, due à des troubles circulatoires.
- C- Se caractérise par la combinaison d'une nécrose ischémique et d'une infection le plus souvent à germe anaérobie.
- D- Survient lorsque la digestion enzymatique domine, comme dans les infections à pyogènes (staphylocoque..).
- E- Le tissu n'est plus reconnaissable.

Source: Q75 P2021

8. Concernant l'apoptose:

- A- Elle joue un rôle dans le maintien de l'homéostasie tissulaire.
- B- Elle assure l'équilibre constant entre mort et prolifération cellulaire.
- C- Elle concerne des groupes de cellules et non pas des cellules isolées comme la nécrose.
- D- Elle permet l'élimination sélective de certaines cellules lésées ou tumorales.
- E- Elle induit toujours une réaction inflammatoire.

Source: Q76 P2021

9. La nécrose calcifiée :

- A- Constitue une variété relativement tardive de nécrose.
- B- Les foyers nécrotiques récents ne se calcifient jamais.
- C- Les calcifications sont fréquentes dans les lésions de nécrose de coagulation récentes.
- D- Elle ne se voit jamais dans la cytotéatonecrose.
- E- Constitue une évolution constante de la nécrose caséuse.

Source: Q77 P2021

10. L'apoptose se déroule en plusieurs phases, lesquelles :

- A- Synthèse d'enzymes permettant la lyse de la cellule.
- B- Condensation des organites intracytoplasmiques.
- C- Perte de cohésion entre les cellules.
- D- Clivage de l'ADN en nucléosomes aboutissant à la formation de corps apoptotique.
- E- Induction d'une réaction inflammatoire.

Source: Q78 P2021

11. L'apoptose cellulaire :

- A- Est une mort programmée.
- B- Elle est bénéfique.
- C- Entraîne toujours une inflammation.
- D- Intéresse un groupe de cellules.
- E- Peut se voir au niveau des tumeurs malignes.

Source: Q27 P2019 RATRAPAGE

12. Toutes ces lésions cellulaires sont réversibles sauf une laquelle :

- A- Atrophie.
- B- Hyperplasie.
- C- Métaplasie.
- D- Nécrose.
- E- Hypertrophie.

Source: Q32 P2019 RATRAPAGE

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐

3. Réponses Adaptatives (Cellule & Tissu)**1. La Métaplasie :**

- A- C'est une anomalie acquise résultant de la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, de structure et de fonction différentes.
- B- Il s'agit d'un changement dans la différenciation cellulaire en réponse à une agression chronique pour aboutir à un tissu mieux adapté à l'agression que le tissu d'origine.
- C- Elle est irréversible intéresse les muqueuses et les tissus conjonctifs.
- D- Elle peut être physiologique.
- E- Elle peut être pathologique.

Source: Q56 P2022

2. L'hyperplasie :

- A- Correspond à l'augmentation du nombre de cellules dans un tissu.
- B- Est habituellement le témoin d'une augmentation de l'activité fonctionnelle.
- C- Est définie par l'augmentation de la taille des cellules.
- D- Survient dans les tissus capables de renouvellement cellulaire.
- E- Peut constituer des nodules visibles macroscopiquement.

Source: Q57 P2022

3. L'hypertrophie cellulaire :

- A- Lésion élémentaire cellulaire survenant suite à une augmentation du métabolisme cellulaire.
- B- C'est l'augmentation du nombre de cellules dans un tissu.
- C- Elle s'observe dans les tissus dont les cellules se divisent peu ou pas (rein, muscle).
- D- Elle survient par l'augmentation de l'activité mécanique d'un organe ou par augmentation du métabolisme cellulaire.
- E- Elle est souvent irréversible.

Source: Q67 P2021

4. L'hyperplasie

- A- Correspond à l'augmentation de la masse d'un tissu, par augmentation du volume cellulaire.
- B- Elle accompagne toujours des modifications de l'architecture tissulaire.
- C- Elle ne concerne que des tissus dont les cellules peuvent se multiplier.
- D- Elle peut être physiologique : augmentation des glandes mammaires au cours d'une grossesse.
- E- C'est un phénomène réversible. Il régresse lorsque le facteur en cause disparaît.

Source: Q68 P2021

5. L'atrophie

- A- Lésion élémentaire cellulaire survenant suite à une diminution de l'activité cellulaire.
- B- Une hypoplasie d'un organe survenant au cours du développement embryonnaire.
- C- Correspond à la diminution de la masse tissulaire.
- D- Elle est liée à une destruction des protéines de structures ou des organites intracellulaires.
- E- Soit par diminution du nombre de cellules fonctionnelles par la nécrose.

Source: Q69 P2021

6. La Dystrophie :

- A- Désigne toute altération cellulaire ou tissulaire acquise, souvent irréversibles liées à un processus inflammatoire.
- B- Elle peut être d'origine vasculaire, hormonale, nerveuse ou métabolique.
- C- Elle correspond à des phénomènes d'adaptation cellulaire.
- D- Elle permet d'ajuster l'activité de la cellule en fonction des modifications durables que lui impose son nouvel environnement.
- E- La dystrophie d'un organe peut combiner des lésions inflammatoires et dysplasiques.

Source: Q70 P2021

7. La Métaplasie

- A- Elle se définit comme une conversion de la forme et de la fonction d'un ensemble de cellules dans un tissu.
- B- Elle intéresse essentiellement les épithéliums de revêtements, mais n'épargne pas les autres tissus.
- C- A un rôle dans l'installation d'un nouveau type de tissu, plus apte à résister aux stimuli pathologiques.
- D- Elle est toujours pathologique.
- E- Est directe lorsqu'elle se forme par modification de la maturation des cellules souches.

Source: Q71 P2021

8. La Métaplasie :

- A- C'est un processus réversible.
- B- Une réponse à une agression chronique pour aboutir à un tissu mieux adapté.
- C- C'est une anomalie acquise résultant de la transformation d'un tissu normal en un autre tissu anormal.
- D- Elle peut être physiologique : métaplasie déciduale du chorion cytogène de l'endomètre.
- E- Elle peut être pathologique secondaire à une cause toxique hormonale ou inflammatoire.

Source: Q13 P2020

9. L'hyperplasie :

- A- C'est l'augmentation du nombre des cellules par division cellulaire accrue.
- B- Intéresse les tissus qui ont la capacité de se diviser exemple : épithélium intestinal.
- C- Elle est réversible à l'arrêt du stimuli à l'inverse d'une néoplasie.
- D- Intéresse le plus souvent les tissus qui sont incapables de se diviser exemple: muscle strié, myocarde.
- E- Peut être associée ou indépendante de l'hypertrophie.

Source: Q4 P2019 & Q17 P2018

10. La Métaplasie

- A- C'est une anomalie acquise résultant de la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, de structure et de fonction différentes, d'architecture normale mais de situation anormale.
- B- Il s'agit d'un changement dans la différenciation cellulaire en réponse à une agression chronique pour aboutir à un tissu mieux adapté à l'agression que le tissu d'origine.
- C- C'est un processus irréversible qui intéresse surtout les tissus épithéliaux, surtout les muqueuses mais aussi les tissus conjonctifs.
- D- Elle peut être physiologique : métaplasie déciduale du chorion cytogène de l'endomètre.
- E- Elle peut être pathologique : secondaire à une cause toxique, hormonale ou inflammatoire.

Source: Q28 P2019 RATRAPAGE & Q18 P2018

11. L'hypertrophie :

- A- Est l'augmentation de la taille des cellules existantes.
 B- Est l'augmentation du nombre des cellules existantes.
 C- Est l'augmentation de la capacité fonctionnelle de la cellule.
 D- Est la synthèse accrue des constituants de la cellule (augmentation du métabolisme, du taux d'ARN messager et de la synthèse protéique).
 E- Intéresse le plus souvent les tissus qui sont incapables de se diviser exemple : muscle strié, myocarde.

Source: Q16 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐

4. Pathologies de La MEC**1. Lesquels sont des constituants de la MEC ?**

- A- Collagène. B- Protéoglycanes. C- Fibronectine.
 D- Kératine. E- Elastine.

Source: Q53 P2022

2. Concernant la fibrose :

- A- Elle résulte d'une accumulation excessive de collagène.
 B- Elle peut être causée par une inflammation chronique.
 C- Elle est toujours réversible.
 D- Elle peut entraîner une diminution de la fonction des organes.
 E- Elle est causée uniquement par des infections.

Source: Q54 P2022

3. L'amylose est caractérisée par :

- A- Un dépôt extracellulaire anormal de protéines amyloïdes.
 B- Une coloration spécifique au Rouge Congo.
 C- Une prolifération de cellules tumorales.
 D- Une altération progressive de la fonction des organes.
 E- Une accumulation de lipides dans la MEC.

Source: Q55 P2022

4. La matrice extracellulaire :

- A- Est une trame extracellulaire à laquelle peuvent s'ancrer les cellules.
 B- Constituée d'une substance fondamentale et de protéines fibreuses.
 C- Sécrétée par les enzymes MMP matrix métalloprotéinases.
 D- Assure la résistance des tissus.
 E- Représente un lieu de diffusion et de stockage des métabolites.

Source: Q102 P2021

5. Le collagène :

- A- Est de même type dans les membranes basales des épithéliums et dans l'os.
 B- Est sécrété par les matrix métallo-protéinases.
 C- Est une glycoprotéine fibreuse.
 D- Se présente souvent sous forme fibrillaire.
 E- Représente 25 % des protéines totales.

Source: Q40 P2020

6. L'amylose :

- A- Est un dépôt tissulaire et intracellulaire d'une substance protéique amyloïde.
 B- Est de diagnostic histologique.
 C- Correspond à un groupe hétérogène de maladies acquises ou héréditaires liées à des dépôts tissulaires.
 D- Est mise en évidence par le rouge Congo, la thioflavine T et le bleu de Paris.
 E- À l'échelle ultrastructurale, c'est une disposition fibrillaire en feuillets bêta plissés.

Source: Q45 P2020

7. L'amylose:

- A- Correspond à un groupe hétérogène de maladies acquises ou héréditaires liées à des dépôts tissulaires.
 B- Est un dépôt intra cellulaire d'une substance protéique amyloïde.
 C- Est de diagnostic histologique.
 D- Peut être mise en évidence par le rouge Congo et la thioflavine T.
 E- A l'échelle ultra structurale : c'est une disposition fibrillaire en feuillets beta plissés.

Source: Q11 P2019

8. L'amylose :

- A- Un groupe de maladies acquises ou héréditaires.
 B- Est un dépôt intracellulaire d'une substance amyloïde.
 C- Le diagnostic de certitude est clinique.
 D- Mise en évidence par le rouge Congo.
 E- A l'échelle ultra structurale : c'est une disposition fibrillaire en feuillets bêta plissés.

Source: Q7 P2019 RATRAPAGE

9. La fibrose :

- A- Est une composante constante de l'inflammation chronique.
 B- Est un mécanisme de la cicatrisation.
 C- Peut conduire à la destruction d'un tissu et à une dysfonction d'organe.
 D- Est secondaire à une augmentation de la synthèse de fibres élastiques.
 E- Est synthétisée par les fibroblastes et les macrophages.

Source: Q22 P2019 RATRAPAGE

10. Parmi ces sites biopsiques lequel ou les quelles est (sont) indiqué (s) dans la recherche de dépôts amyloïdes :

- A- Biopsie hépatique.
- B- Biopsie des glandes salivaires accessoires.
- C- Biopsie cérébrale.
- D- Muqueuse rectale.
- E- Biopsie osseuse.

Source: Q33 P2019 RATRAPAGE

11. L'amylose :

- A- Correspond à un groupe hétérogène de maladies acquise ou héréditaires liées à des dépôts tissulaires.
- B- Est un dépôt tissulaire et intracellulaire d'une substance protéique amyloïde.
- C- Est de diagnostic histologique.
- D- Mise en évidence par le rouge congo ,thioflavine T, bleu de paris.
- E- A l'échelle ultra structurale : c'est une disposition fibrillaire en feuillets bêta plissé.

Source: Q36 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐

5. Athérosclérose

1. Quelle est la définition actuelle de l'athérosclérose selon l'OMS ?

- A- Une maladie infectieuse des artères.
- B- Une pathologie inflammatoire et lipidique des artères.
- C- Un vieillissement normal des vaisseaux sanguins.
- D- Une altération des veines due à une hypertension.
- E- Une déformation congénitale des vaisseaux.

Source: Q61 P2022

2. Où se développe préférentiellement l'athérosclérose ?

- A- Dans les veines profondes.
- B- Dans les artères de moyen et gros calibre.
- C- Dans les artères coronaires.
- D- Dans les capillaires sanguins.
- E- Au niveau des bifurcations artérielles.

Source: Q62 P2022

3. Quelles sont les étapes de formation de la plaque d'athérome ?

- A- Lésion endothéliale.
- B- Accumulation de lipides.
- C- Régression spontanée après 50 ans.
- D- Inflammation et formation de cellules spumeuses.
- E- Développement d'une coque fibreuse.

Source: Q63 P2022

4. Quelle est la principale complication des plaques instables ?

- A- Une hémorragie locale.
- B- Une embolie graisseuse.
- C- Une rupture avec formation d'un thrombus.
- D- Une dilatation progressive de l'artère.
- E- Une cicatrisation rapide.

Source: Q64 P2022

5. Quelle est la principale complication de la rupture d'une plaque d'athérome ?

- A- Une hémorragie digestive.
- B- Une thrombose avec formation d'un caillot.
- C- Une infection bactérienne.
- D- Une hypertension artérielle.
- E- Une hypotension sévère.

Source: Q65 P2022

6. Quelle est l'artère la plus souvent touchée par l'athérosclérose ?

- A- La veine cave inférieure.
- B- L'aorte abdominale.
- C- L'artère pulmonaire.
- D- La veine saphène.
- E- L'artère iliaque.

Source: Q66 P2022

7. L'athérosclérose, est définie par l'accumulation des dépôts de cholestérol au niveau de :

- A- L'intima des artères de gros et moyen calibre.
- B- L'intima des grosses veines.
- C- Des coronaires.
- D- La couche musculaire des veines.
- E- Des artères des membres inférieur.

Source: Q61 P2021

8. Parmi les facteurs de risques de l'athérosclérose on peut citer :

- A- L'âge.
- B- Le diabète.
- C- Les facteurs génétiques.
- D- Une alimentation pauvre en graisses animales et en protéines.
- E- Le tabac.

Source: Q62 P2021

9. L'examen microscopique d'une paroi artérielle montre une accumulation des macrophages spumeux dans l'intima. Il s'agit de :

- A- Pustule.
- B- Plaque d'athérome.
- C- Strie lipidique.
- D- Stéatose.
- E- Plaque d'athérome calcifiée.

Source: Q63 P2021 & Q31 P2020 & Q34 P2019 & Q1 P2018

10. La plaque d'athérosclérose se complique de :

- A- Thrombose.
- B- Anévrysme.
- C- Rupture.
- D- Embolie.
- E- Cancérisation.

Source: Q64 P2021 & Q4 P2019 RATRAPAGE

11. Parmi ces facteurs, un seul n'intervient pas dans l'athérosclérose :

- A- Altération endothéliale. B- Diabète.
C- Hypotension orthostatique. D- Hypercholestérolémie.
E- Âge avancé.

Source: Q30 P2020 & Q35 P2019 & Q2 P2018

12. Dans l'athérosclérose, les dépôts de cholestérol se voient au niveau :

- A- L'adventice des parois vasculaires.
B- L'intima des artères de gros et moyen calibre.
C- L'intima des grosses veines.
D- L'endothélium capillaire.
E- La couche musculaire des veines.

Source: Q32 P2020 & Q3 P2019 RATTRAPAGE & Q3 P2018

13. Parmi les lésions suivantes, celle ou celles qui peuvent compliquer l'athérosclérose sont :

- A- Syndrome d'angor intestinal.
B- Infarctus cérébral.
C- Ischémie d'un membre inférieur.
D- Infarctus rénal.
E- Thrombose de la veine cave.

Source: Q33 P2020 & Q4 2018

14. Parmi les propositions suivantes concernant l'athérosclérose, celle ou celles qui sont exactes sont :

- A- Les stries lipidiques correspondent à des lésions évoluées.
B- Les lésions débutent dans la média des artères.
C- La veine cave est rarement atteinte.
D- Les lésions débutent dès la vie intra-utérine.
E- La plaque se développe dans l'intima et refoule la média en profondeur.

Source: Q34 P2020

15. L'athérosclérose présente les caractéristiques suivantes :

- A- Est une lésion artérielle.
B- Est une inflammation chronique complexe.
C- Prédomine dans l'intima des vaisseaux.
D- Touche les artères de moyen et de gros calibre préférentiellement.
E- Peut être à l'origine de survenue de néoplasie.

Source: Q33 P2019

16. Parmi les complications de la plaque d'athérome une seule est fausse, laquelle ?

- A- Thrombose.
B- Anévrysme.
C- Infarctus.
D- Nécrose fibrinoïde.
E- Calcification.

Source: Q5 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐

6. Pathologie Vasculaire & Troubles Circulatoires

1. la variété d'embolie la plus fréquente est :

- A- Gazeuse. B- Parasitaire. C- Cruorique.
D- Graisseuse. E- Suppurée.

Source: Q67 P2022

2. L'œdème tissulaire :

- A- Peut être hémodynamique ou lésionnel.
B- Est riche en protéines dans le transsudat.
C- La pression capillaire est augmentée dans l'exsudat.
D- Entraîne une nécrose tissulaire s'il se prolonge.
E- L'œdème aigu du poumon est toujours d'origine cardiogénique.

Source: Q41 P2020

3. Le foie cardiaque :

- A- Est dû à l'élévation des pressions des oreillettes droites, veines caves et veines sus hépatiques.
B- Est responsable d'une hépatomégalie lisse, ferme et rouge.
C- Est la conséquence d'une insuffisance cardiaque gauche.
D- Il existe une hypoxie des hépatocytes centro et médio-lobulaires.
E- Le foie devient interverti avec des lobules centrés par des espaces portes.

Source: Q42 P2020

4. Quel est le terme qui désigne l'arrêt de l'apport en oxygène dans un tissu ou un organe ?

- A- Hypoxie. C- Gangrène. E- Infarctus.
B- Anoxie. D- Ischémie.

Source: Q10 P2019

5. Le poumon cardiaque :

- A- Se voit dans l'insuffisance ventriculaire droite.
B- Se voit dans l'insuffisance ventriculaire gauche.
C- Correspond à l'incapacité du coeur à évacuer le sang veineux pulmonaire.
D- Est dû à l'augmentation des pressions dans la Circulation Veineuse pulmonaire.
E- Le poumon est de couleur foncé.

Source: Q12 P2019 & Q34 P2018

6. Le foie cardiaque:

A- Se voit dans l'insuffisance ventriculaire gauche.

B- Due à une élévation des pressions dans l'oreillette droite, la veine cave et veines sus hépatiques.

C- Correspond à une Hépatomégalie ferme rouge avec veines sus hépatiques dilatées.

D- L'hypoxie altère les hépatocytes centro et médio-lobulaires.

E- La chronicité entraîne une fibrose centro-lobulaire puis une cirrhose.

Source: Q13 P2019 & Q35 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

7. Troubles des Métabolismes

! Aucune question n'a encore été posée à propos de ce cours.

Cependant, des informations similaires peuvent être trouvées dans d'autres cours

[Par exemple : Amylose dans le cours n°4 , Pathologie Vasculaire dans le cours n°7 (Q4)].

RÉPONSES**1. Introduction à l'ACP**

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☒	☐	☐
Q4	☐	☒	☒	☐	☐

2. Lésions Cellulaires & Tissulaires

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☐	☐	☐	☐
Q3	☒	☐	☐	☒	☐
Q4	☐	☒	☐	☐	☒
Q5	☐	☒	☒	☒	☐
Q6	☒	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q7	☐	☒	☒	☐	☐
Q8	☒	☒	☐	☒	☐
Q9	☒	☒	☐	☐	☐
Q10	☒	☐	☒	☒	☐
Q11	☒	☒	☐	☒	☐
Q12	☐	☐	☐	☒	☐

3. Réponses Adaptatives (Cellule & Tissu)

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☒	☒
Q2	☒	☒	☐	☒	☒
Q3	☒	☐	☒	☒	☐
Q4	☐	☐	☒	☒	☒
Q5	☒	☐	☒	☒	☐
Q6	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q7	☒	☒	☒	☐	☐
Q8	☒	☒	☐	☒	☒
Q9	☒	☒	☒	☐	☒
Q10	☒	☒	☐	☒	☒
Q11	☒	☐	☒	☒	☒

4. Pathologies de La MEC

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☒	☐	☒	☐
Q3	☒	☒	☐	☒	☐
Q4	☒	☒	☐	☒	☒
Q5	☐	☐	☒	☒	☒
Q6	☐	☒	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q7	☒	☐	☒	☒	☒
Q8	☒	☐	☐	☒	☒
Q9	☐	☐	☒	☒	☐
Q10	☐	☒	☐	☒	☐
Q11	☒	☐	☒	☒	☒

5. Athérosclérose

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☐	☐
Q2	☐	☒	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☐	☒	☐
Q4	☐	☐	☒	☐	☐
Q5	☐	☒	☐	☐	☐
Q6	☐	☒	☐	☐	☐
Q7	☒	☐	☒	☐	☒
Q8	☒	☒	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q9	☐	☐	☒	☐	☐
Q10	☒	☒	☒	☒	☐
Q11	☐	☐	☒	☐	☐
Q12	☐	☒	☐	☐	☐
Q13	☒	☒	☒	☒	☐
Q14	☐	☐	☐	☒	☒
Q15	☒	☒	☒	☒	☐
Q16	☐	☐	☐	☒	☐

6. Pathologie Vasculaire & Troubles Circulatoires

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☒	☐	☐
Q2	☒	☐	☐	☒	☐
Q3	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☒	☐	☐	☐
Q5	☐	☒	☒	☒	☒
Q6	☐	☒	☒	☒	☒

7. Troubles des Métabolismes

! Aucune question n'a encore été posée à propos de ce cours.

Cependant, des informations similaires peuvent être trouvées dans d'autres cours

[Par exemple : Amylose dans le cours n°4 , Pathologie Vasculaire dans le cours n°7 (Q4)].

INFLAMMATION

1. Processus Inflammatoire

1. Parmi les propositions suivantes, quelle est la phase initiale du processus inflammatoire ?

- A- La réaction cellulaire.
- B- La déterision.
- C- La réaction vasculo-sanguine.
- D- La cicatrisation.
- E- La réparation tissulaire.

Source: Q68 P2022

2. Le processus inflammatoire :

- A- Est toujours bénéfique.
- B- A pour but d'éliminer l'agent causal.
- C- Tente de réparer les effets de l'agression.
- D- Peut être nocif.
- E- A des causes exogènes et endogènes.

Source: Q69 P2022

3. Parmi les signes cliniques suivants lesquels témoignent d'une inflammation aigue :

- A- Rougeur.
- B- Chaleur.
- C- Douleur.
- D- Fibrose.
- E- Tuméfaction.

Source: Q81 P2021

4. Les mastocytes :

- A- Sont des cellules conjonctives.
- B- Interviennent dans la congestion passive.
- C- Sont présents uniquement dans les tissus.
- D- Font partie des cellules de l'inflammation aiguë.
- E- Sont appelées aussi des basophiles.

Source: Q5 P2020

5. Le facteur étiologique de l'œdème inflammatoire est une :

- A- Augmentation de la pression veineuse.
- B- Hypo protéinémie.
- C- Rétention hydrosodée.
- D- Augmentation de la perméabilité vasculaire des capillaires et des veinules.
- E- Augmentation de la perméabilité artérielle.

Source: Q6 P2020 & Q24 P2019

6. La diapédèse :

- A- Intéresse uniquement les polynucléaires éosinophiles.
- B- N'intéresse jamais les mastocytes.
- C- Peut intéresser les cellules épithélioïdes.
- D- Est la migration des cellules inflammatoires en dehors de la microcirculation.
- E- Précède la phase cellulaire.

Source: Q7 P2020 & Q27 P2019

La même question avec la même réponse en 2019, mais les propositions A et B modifiées

A- Intéresse uniquement les polynucléaires neutrophiles.

B- N'intéresse pas les mastocytes.

7. L'Érythrodiapédèse est :

- A- Un phénomène biologique normal.
- B- Un phénomène pathologique.
- C- Impliqué dans les inflammations purulentes.
- D- Secondaire à des lésions des parois capillaires.
- E- Traduit par le passage des globules rouges en dehors de la microcirculation.

Source: Q8 P2020

8. Concernant la congestion active

- A- Résulte de la dilatation des vaisseaux.
- B- Macroscopiquement le tissu est de couleur rouge.
- C- Elle ne s'efface pas à la vitro pression.
- D- Due à une hyper activité des tissus.
- E- Ces conséquences sont souvent bénéfiques.

Source: Q15 P2019

9. Les mastocytes:

- A- Sont des cellules d'origine myéloïde.
- B- Interviennent dans la congestion active.
- C- Sont présents uniquement dans la circulation sanguine.
- D- Font partie des cellules de l'inflammation aigue.
- E- Sont appelées aussi des basophiles.

Source: Q23 P2019

10. L'inflammation aigue :

- A- Intéresse tous les tissus de l'organisme.
- B- Limité au foyer inflammatoire.
- C- N'intéresse pas la cornée et le cartilage.
- D- Prend naissance à partir des épithéliums.
- E- Peut-être néfaste.

Source: Q25 P2019

11. L'erythrodiapédèse est :

- A- Un phénomène biologique normal.
- B- Un phénomène pathologique.
- C- Impliqué dans les inflammations hémorragiques.
- D- Secondaire à des lésions des parois capillaires.
- E- Traduit le passage des globules rouges en dehors de la microcirculation.

Source: Q28 P2019

12. Les macrophages tissulaires :

- A- Font partie du système des phagocytes mononuclées.
- B- Sont des macrophages fixes.
- C- Sont des macrophages circulants.
- D- Interviennent au cours de l'inflammation aigue et chronique.
- E- Ne sont pas retrouvés dans le parenchyme rénal.

Source: Q30 P2019

13. Les mastocytes :

- A- Sont des cellules d'origine épithéliale.
- B- Interviennent dans la congestion active.
- C- Sont présents dans la circulation sanguine.
- D- Font partie des cellules de l'inflammation aiguë.
- E- Sont des macrophages.

Source: Q8 P2019 RATRAPAGE

14. L'œdème inflammatoire est :

- A- Un transsudat.
- B- Lié à une hypo protéinémie.
- C- Un facteur favorisant la diapédèse.
- D- Une augmentation de la perméabilité vasculaire des capillaires et des veinules.
- E- Une augmentation de la perméabilité artérielle.

Source: Q9 P2019 RATRAPAGE

15. Les macrophages tissulaires :

- A- Font partie du système des phagocytes mononucléés.
- B- Sont des macrophages fixes.
- C- Sont des macrophages circulants.
- D- Interviennent au cours de l'inflammation uniquement chronique.
- E- Sont présents dans le parenchyme hépatique.

Source: Q12 P2019 RATRAPAGE

16. L'inflammation peut être néfaste du fait :

- A- De l'agressivité de l'agent pathogène.
- B- Du siège de l'inflammation par atteinte surtout des organes vitaux.
- C- Des anomalies régulatrices du processus inflammatoire.
- D- Des anomalies qualitatives ou quantitatives des cellules de l'inflammation.
- E- Des lésions minimales du tissu conjonctif.

Source: Q14 P2019 RATRAPAGE

17. Les épithéliums de revêtement :

- A- N'ont pas de rôle actif dans le déroulement de la réaction inflammatoire.
- B- Peuvent être altérés par l'inflammation.
- C- Interviennent dans l'inflammation.
- D- Sont très vascularisés.
- E- Peuvent être cicatrisés sur un mode métaplasique.

Source: Q15 P2019 RATRAPAGE

18. La cellule épithélioïde est :

- A- Un macrophage.
- B- Une cellule ayant perdu la fonction de déplacement et de phagocytose.
- C- Un plasmocyte.
- D- Une cellule épithéliale.
- E- Une histiomonocyte.

Source: Q16 P2019 RATRAPAGE

19. Les polynucléaires neutrophiles :

- A- Sont des microphages.
- B- Sont les premières cellules qui interviennent dans l'inflammation aiguë.
- C- Leur demi vie est courte.
- D- Ne sont pas intéressés par la diapédèse.
- E- Sécrètent les médiateurs chimiques.

Source: Q19 P2019 RATRAPAGE

20. Une des cellules inflammatoires suivantes est évocatrice d'une inflammation allergique ; laquelle :

- A- Lymphocyte.
- B- Polynucléaire neutrophile.
- C- Polynucléaire éosinophile.
- D- Plasmocyte.
- E- Polynucléaire basophile.

Source: Q10 P2018

Commentaire : faux CT

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐

2. Réparation & Cicatrisation**1. Les étapes de la réparation tissulaire :**

- A- Formation du bourgeon charnu inflammatoire.
- B- Régénération.
- C- Maturation du tissu de granulation.
- D- Réaction inflammatoire.
- E- Coaptation.

Source: Q73 P2022

2. Facteurs nécessaires à une bonne cicatrisation :

- A- Corticoïdes.
- B- Carence en vit C.
- C- Détersion.
- D- Bonne vascularisation.
- E- Siège de la lésion.

Source: Q74 P2022 & Q22 P2020

3. La chéloïde est :

- A- Une cicatrice cutanée atrophique.
- B- Une cicatrice cutanée hypertrophique.
- C- Une réparation épithéliale avec absence des structures piloannexielles.
- D- Marquée par une disposition anarchique et tourbillonnante des fibres de collagène au niveau du derme.
- E- Peut être traitée par les infiltrations aux corticoïdes.

Source: Q83 P2021

4. La cicatrice hypertrophique est :

- A- Une chéloïde.
- B- Un excès du tissu conjonctif collagène par excès d'activité des myofibroblastes.
- C- Une cicatrice qui a tendance à s'atténuer dans le temps.
- D- Une cicatrice qui persiste ou augmente de volume au cours du temps.
- E- Un mode de cicatrisation ad integrum.

Source: Q9 P2020 & Q13 P2019 RATRAPAGE

5. Le Bourgeon charnu :

- A- Est constitué en surface par un enduit fibrino-leucocytaire.
- B- Est constitué en profondeur par des néo vaisseaux.
- C- Les fibroblastes et les myofibroblastes synthétisent la fibrine.
- D- Peut évoluer vers une cicatrice riche en collagène.
- E- Prend la place de l'infiltrat inflammatoire et des tissus nécrosés.

Source: Q10 P2020 & Q2 P2019

6. La chéloïde est une cicatrice pathologique caractérisée par :

- A- Hypertrophie.
- B- Caractère racial.
- C- Excès en fibres de collagènes.
- D- Richesse en fer.
- E- Richesse en adipocytes.

Source: Q24 P2020

7. La cicatrisation :

- A- Est la restitution des tissus endommagés.
- B- Est la phase initiale du processus inflammatoire.
- C- Peut être anormale et devient pathologique.
- D- Se produit par deux phénomènes : la régénération et la cicatrisation.
- E- Aboutit toujours à une restitution ad integrum.

Source: Q25 P2020

8. La coaptation spontanée (contraction du foyer inflammatoire) est liée à l'action des :

- A- Polynucléaires neutrophiles.
- B- Macrophages.
- C- Myofibroblastes.
- D- Points de sutures chirurgicales.
- E- Fibroblastes.

Source: Q26 P2020

9. La contraction du tissu de réparation au cours de la phase de cicatrisation d'une réaction inflammatoire est liée à l'action des :

- A- Macrophages.
- B- Lymphocytes.
- C- Myofibroblastes.
- D- Cellules géantes multinucléées.
- E- Fibroblastes.

Source: Q1 P2019

10. Détersion/coaptation :

- A- La détersion correspond à l'élimination des débris tissulaires nécrosés, des agents pathogènes, des corps étrangers.
- B- La détersion interne est assurée par les lymphocytes et les plasmocytes.
- C- La détersion interne est assurée par les PNN et les macrophages.
- D- Une détersion incomplète empêche la réparation tissulaire.
- E- La coaptation correspond à l'accolement des bords de la perte de substance après détersion et favorise la cicatrisation.

Source: Q3 P2019

11. La chéloïde est :

- A- Une cicatrice cutanée atrophique.
- B- Une cicatrice cutanée hypertrophique.
- C- Une réparation épithéliale avec absence des structures piloannexielles.
- D- Une réparation ad integrum.
- E- Marquée par une disposition anarchique et tourbillonnante des fibres de collagène au niveau du derme.

Source: Q14 P2019

12. Bourgeon charnu :

- A- Est constitué en surface par un enduit fibrino-leucocytaire.
- B- Prend la place de l'infiltrat inflammatoire et des tissus nécrosés.
- C- Les fibroblastes et les myofibroblastes synthétisent la fibrine.
- D- Peut évoluer vers une cicatrice riche en collagène.
- E- Fait partie de la phase vasculo-exudative.

Source: Q17 P2019 RATRAPAGE

13. Réparation/Cicatrisation :

- A- S'observe quand le tissu conjonctif est lésé.
- B- Est un mécanisme physiologique.
- C- N'intéresse que certains types de tissus.
- D- La coaptation et la détersion sont des conditions nécessaires pour la cicatrisation.
- E- Le bourgeon charnu remplace la zone endommagée.

Source: Q18 P2019 RATRAPAGE

14. La cicatrisation :

- A- Comporte une sclérose.
- B- Est accompagnée par une régénération épithéliale en cas d'ulcération au niveau de la peau.
- C- N'est pas affectée en cas de diabète.
- D- Peut être anormale sur la peau (chéloïde).
- E- Est la phase terminale du processus inflammatoire.

Source: Q21 P2019 RATRAPAGE

15. Les facteurs qui interviennent dans la réparation/cicatrisation sont :

- A- La déterision. B- L'âge.
C- La nutrition. D- Le nombre des globules rouge.
E- La vascularisation.

Source: Q36 P2019 RATRAPAGE

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐

3. Formes de l'Inflammation

1. La phase exsudative de l'inflammation aigue se caractérise par :

- A- Congestion passive.
B- Œdème.
C- Mobilisation et multiplication des histiocytes.
D- Diapédèse des polynucléaires.
E- infiltration lympho-plasmocytaire.

Source: Q70 P2022

2. Un abcès se distingue d'un phlegmon par :

- A- Richesse en polynucléaires.
B- Présence de polynucléaires altérés.
C- Aspect collecté de la lésion.
D- Étendue des thromboses veineuses.
E- Intensité de l'exsudat fibrineux.

Source: Q71 P2022

3. Une inflammation granulomateuse tuberculoïde sans nécrose caséuse est :

- A- Une inflammation chronique.
B- Faite de cellules géantes de types Muller.
C- Signe toujours une infection tuberculose.
D- Faite de lymphocytes, de cellules épithélioïdes et de cellules géantes type Langhans.
E- Peut être due à une sarcoïdose.

Source: Q72 P2022

4. Parmi les affections suivantes, les quelles sont des inflammations chroniques :

- A- Réaction à corps étranger.
B- Alvéolite fibrinoleucocytaire.
C- Nodule tuberculeux calcifié.
D- Cholécystite gangréneuse.
E- Cirrhose.

Source: Q75 P2022

5. La tuberculose :

- A- Est liée à une infection par un virus.
B- Peut comporter du caséum.
C- Survient uniquement au niveau des poumons.
D- Est caractérisée par des follicules épithélioïdes et giganto-cellulaires d'âge identique.
E- L'agent responsable est le mycobacterium tuberculosis.

Source: Q82 P2021

6. L'Inflammation chronique :

- A- Est un état d'équilibre entre des phénomènes de destruction et de réparation.
B- Elle ne s'accompagne pas systématiquement d'une fibrose.
C- Les éléments cellulaires tels que les macrophages, les lymphocytes, les plasmocytes, prédominent.
D- L'inflammation chronique persiste tant que le facteur d'agression n'est pas supprimé ou neutralisé.
E- Constitue un état précancéreux.

Source: Q11 P2020

7. Les cellules épithélioïdes d'un granulome proviennent de :

- A- Macrophages.
B- Cellules fibroblastiques.
C- Cellules épithéliales.
D- Cellules folliculaires dendritiques.
E- Lymphocytes.

Source: Q38 P2020

8. L'inflammation granulomateuse est :

- A- Un granulome inflammatoire.
B- Une inflammation chronique.
C- Est marqué par un granulome particulier par son architecture et sa composition cellulaire.
D- Évolue toujours vers la résolution.
E- Peut être précédée par une inflammation aigue.

Source: Q26 P2019

9. Les principaux types d'évolution de l'inflammation aigue :

- A- Résolution. B- Abcédation. C- Cicatrisation.
D- Inflammation chronique.
E- Transformation maligne.

Source: Q29 P2019

10. Toutes ces lésions histologiques peuvent être dues au bacille tuberculeux :

- A- Congestion vasculaire, œdème, diapédèse et infiltration des cellules mononuclées.
B- Caséification.
C- Réaction granulomateuse.
D- Nécrose hémorragique.
E- Réaction inflammatoire commune.

Source: Q31 P2019

II - INFLAMMATION

11. La cellule géante de Muller :

- A- Fait partie du granulome tuberculoïde.
- B- Est une cellule du système des phagocytes mononucléés.
- C- Provient de la fusion des polynucléaires.
- D- Peut se voir dans les granulomes à corps étrangers.
- E- Est une cellule multinucléée.

Source: Q32 P2019

12. Toutes ces inflammations sont des inflammations aiguës purulentes sauf une :

- A- Pustule.
- B- Abscess.
- C- Phlegmon.
- D- Empyème.
- E- Gangrène.

Source: Q20 P2019 RATRAPAGE

13. Inflammation chronique spécifique :

- A- Succède à un épisode d'inflammation aiguë d'origine bactérienne.
- B- C'est quand l'aspect morphologique permet d'évoquer l'agent causal.
- C- Elle repose sur l'activation des PNN.
- D- Elle peut être granulomateuse.
- E- La présence de granulomes épithélio-gigantocellulaires avec nécrose caséuse est pathognomonique d'une tuberculose.

Source: Q23 P2019 RATRAPAGE

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐

4. Aspects Anato-Cytopathologiques des infections

1. Parmi les mécanismes d'inflammation virale, on retrouve :

- A- Production de cytokines pro-inflammatoires.
- B- Activation des lymphocytes T.
- C- Formation d'inclusions virales.
- D- Activation des polynucléaires éosinophiles.
- E- Absence de réponse immunitaire.

Source: Q76 P2022

2. Quels virus sont associés à un effet oncogénique ?

- A- Virus Epstein-Barr (EBV).
- B- Virus de l'hépatite B (HBV).
- C- Virus du papillome humain (HPV).
- D- Virus de la grippe (Influenza).
- E- Virus de l'hépatite C (HCV).

Source: Q77 P2022

Vous pouvez également trouver les informations de cette question dans le cours < Carcinogenèse >

ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

3. Dans l'inflammation virale, le pathologiste peut :

- A- Etablir le diagnostic de certitude sans recours aux techniques virologiques.
- B- Constater les lésions cellulaires et tissulaires.
- C- Mettre en évidence les protéines des virions par technique immunohistochimique.
- D- Mettre en évidence les acides nucléiques viraux par hybridation in situ.
- E- Evaluer le retentissement tissulaire et cellulaire.

Source: Q103 P2021

4. Ce qui caractérise le mieux une inflammation virale est :

- A- Un infiltrat inflammatoire aigu.
- B- Un infiltrat inflammatoire chronique.
- C- Des inclusions intra-nucléaires.
- D- Un infiltrat granulomateux.
- E- Un infiltrat tuberculoïde.

Source: Q43 P2020

5. L'inflammation de l'angine diphthérique est une inflammation :

- A- Fibrineuse.
- B- Hémorragique.
- C- Congestive et œdémateuse.
- D- Nécrosante.
- E- Purulente.

Source: Q44 P2020

6. Parmi les virus épidermotropes :

- A- Les virus du groupe herpès.
- B- HIV.
- C- Les papilloma virus.
- D- Epstein Barr virus.
- E- Virus de la rubéole.

Source: Q6 P2019 & Q6 P2019 RATRAPAGE & Q37 P2018

7. Parmi les virus lymphotropes :

- A- Virus de la rubéole.
- B- HIV.
- C- Virus d'Epstein Barr.
- D- Herpes virus.
- E- Papilloma virus.

Source: Q7 P2019

8. La voie de pénétration du virus de la poliomyélite dans l'organisme est :

- A- La voie respiratoire.
- B- La voie cutanée ou muqueuse.
- C- La voie sanguine.
- D- La voie digestive.
- E- La voie maternelle.

Source: Q8 P2019 & Q38 P2018

9. Les lésions directes dues aux virus :

- A- Sont appelées effets cytopathogènes.
- B- Sont le fait de la réponse immunitaire.
- C- Responsables de l'apparition de cancer.
- D- Facilitent le diagnostic histopathologique.
- E- Apparaissent seulement en microscopie électronique.

Source: Q9 P2019

II - INFLAMMATION

10. Un processus inflammatoire qui se poursuit depuis 3 mois comprend la transformation des macrophages tissulaires en cellules épithélioïdes il existe également des lymphocytes ,au fil du temps , les fibroblastes déposent du collagène au fur et à mesure que l'inflammation guérit, ces événements sont plus susceptibles de se produire comme une réponse inflammatoire à laquelle des agents infectieux suivants ? La RJ

- A- Mycobacterium tuberculosis.
- B- Pseudomonas aeruginosa.
- C- Cytomegalovirus.
- D- Giardia lamblia.
- E- Treponema pallidum.

Source: Q39 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐

5. Immunopathologie

1. L'aspect histopathologique commun des affections auto-immunes est celui d'une

- A- Inflammation tuberculoïde.
- B- Une inflammation subaiguë.
- C- Une vascularite.
- D- Une inflammation chronique.
- E- Une atrophie tissulaire.

Source: Q78 P2022

2. Le rejet aigue d'un greffon hépatique se présente par :

- A- Des lésions de portite.
- B- Une fibrose hépatique.
- C- Une cholangite.
- D- Une ductopénie.
- E- Des lésions d'endothélites.

Source: Q79 P2021

3. Le rejet chronique d'un greffon est reconnu par la présence :

- A- Des lésions d'endothélite.
- B- Des remaniements œdémateux et hémorragiques tissulaires.
- C- Une fibrose tissulaire.
- D- Une atrophie des structures épithéliales tissulaires.
- E- Un épaissement des parois vasculaires.

Source: Q80 P2021

ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

4. L'infiltrat cellulaire témoin d'une intradermo-réaction positive comprend principalement à 48 hrs : La RJ

- A- Des LB.
- B- Des mastocytes.
- C- Des LT supresseurs.
- D- Des LT et des macrophages.
- E- Des polynucléaire.

Source: Q13 P2018

5. Quel est le paramètre clinique essentiel permettant d'apprécier l'intensité d'une réaction d'hypersensibilité retardée après intradermo-réaction à la tuberculose ?

- A- Œdème.
- B- Érythème.
- C- Induration.
- D- Nécrose.
- E- Fièvre.

Source: Q14 P2018

6. Un facteur auto immun intervient dans la physiopathologie :

- A- La maladie de Basedow.
- B- L'adénome thyroïdien toxique.
- C- La thyroïdite subaiguë type de Quervain.
- D- La thyroïdite chronique de Hashimoto.
- E- L'épithélium thyroïdien papillaire.

Source: Q15 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

RÉPONSES

1. Processus Inflammatoire

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☒	☐	☐
Q2	☐	☒	☒	☒	☒
Q3	☒	☒	☒	☐	☒
Q4	☐	☐	☒	☒	☐
Q5	☐	☐	☐	☒	☐
Q6	☐	☒	☐	☒	☒
Q7	☐	☒	☐	☒	☒
Q8	☒	☒	☐	☒	☒
Q9	☒	☒	☐	☒	☐
Q10	☐	☐	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q11	☐	☒	☒	☒	☒
Q12	☒	☒	☐	☒	☐
Q13	☐	☒	☒	☒	☐
Q14	☐	☐	☒	☐	☐
Q15	☒	☒	☐	☐	☒
Q16	☒	☒	☐	☐	☐
Q17	☐	☒	☐	☐	☐
Q18	☒	☒	☒	☒	☒
Q19	☐	☒	☐	☐	☒
Q20	☐	☐	☒	☐	☐

2. Réparation & Cicatrisation

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☒	☐
Q2	☐	☐	☒	☒	☒
Q3	☐	☒	☐	☒	☒
Q4	☐	☒	☒	☐	☐
Q5	☒	☒	☐	☒	☒
Q6	☒	☒	☒	☐	☐
Q7	☒	☐	☒	☒	☐
Q8	☐	☐	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q9	☐	☐	☒	☐	☐
Q10	☒	☐	☒	☒	☒
Q11	☐	☒	☒	☐	☒
Q12	☒	☒	☐	☒	☐
Q13	☐	☒	☐	☒	☒
Q14	☐	☒	☐	☒	☒
Q15	☒	☒	☒	☐	☒

3. Formes de l'Inflammation

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☒	☐
Q2	☐	☐	☒	☐	☐
Q3	☒	☐	☐	☒	☒
Q4	☒	☐	☒	☐	☒
Q5	☐	☒	☐	☐	☒
Q6	☒	☐	☒	☒	☒
Q7	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q8	☐	☒	☒	☐	☒
Q9	☒	☒	☒	☒	☐
Q10	☒	☒	☒	☐	☒
Q11	☒	☐	☐	☒	☒
Q12	☐	☐	☐	☐	☒
Q13	☒	☒	☐	☒	☐

4. Aspects Anato- Cytopathologiques des infections

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☒	☐	☒
Q3	☐	☒	☒	☒	☒
Q4	☐	☐	☒	☐	☐
Q5	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q6	☒	☐	☒	☐	☐
Q7	☒	☒	☒	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☒	☐
Q9	☒	☐	☐	☒	☐
Q10	☒	☐	☐	☐	☐

5. Immunopathologie

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☒	☐	☐
Q2	☒	☐	☒	☐	☒
Q3	☐	☐	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☐	☐	☒	☐
Q5	☐	☐	☒	☐	☐
Q6	☒	☐	☐	☒	☐

CANCÉROLOGIE

1. Tumeurs & Processus Tumorale

1. La cellule cancéreuse est :

- A- Le support de la malignité.
- B- La base du diagnostic cytologique des cancers.
- C- Se nourrit du stroma tumoral.
- D- L'absence d'atypies nucléaires élimine le diagnostic de malignité.
- E- Possède des anomalies intéressant uniquement le noyau.

Source: Q79 P2022

2. La métastase :

- A- Est de même nature que la tumeur primitive.
- B- Représente la preuve formelle de la nature maligne d'une tumeur.
- C- Seules les tumeurs bénignes donnent de métastases.
- D- Le mélanome malin est considéré comme une tumeur maligne hautement métastatique.
- E- La voie lymphatique est la principale voie de dissémination des carcinomes.

Source: Q80 P2022 & Q92 P2021

3. La principale caractéristique d'une tumeur maligne est :

- A- La mauvaise limitation.
- B- Les mitoses atypiques.
- C- La survenue de métastases.
- D- Les atypies cytonucléaires.
- E- Sa croissance rapide.

Source: Q83 P2022

4. Toutes ces tumeurs sont malignes :

- A- Fibrome.
- B- Ostéosarcome.
- C- Fibrosarcome.
- D- Lymphome.
- E- Carcinome épidermoïde.

Source: Q84 P2021

5. Parmi les tumeurs suivantes, laquelle (lesquelles) ne donne (nt) pas de métastase :

- A- Carcinome basocellulaire.
- B- Adénome tubuleux ou villositaire.
- C- Lipome.
- D- Ostéosarcome.
- E- Mélanome.

Source: Q86 P2021

6. Une tumeur bénigne

- A- Est une néoplasie.
- B- Ne donne jamais de métastase sauf pour quelques cas exceptionnels.
- C- Récidive après exérèse totale.
- D- Ressemble à un tissu normal de référence.
- E- Se transforme toujours en une tumeur maligne.

Source: Q87 P2021

7. Toutes ces tumeurs sont malignes :

- A- Mélanome.
- B- Ostéosarcome.
- C- Naevus.
- D- Lymphome.
- E- Sarcome.

Source: Q89 P2021

8. Le stroma des cancers :

- A- Il est de nature conjonctive.
- B- Il est dépourvu de vascularisation.
- C- C'est un tissu néoformé.
- D- Il assure la nutrition des cancers.
- E- L'un des défis actuels est d'élaborer des outils pharmacologiques capables d'inhiber la croissance des vaisseaux induite au cours de la croissance tumorale.

Source: Q90 P2021

*Vous pouvez également trouver les informations de cette question dans le cours
< Progression tumorale >*

9. La cellule cancéreuse est :

- A- Le support de la malignité.
- B- La base du diagnostic cytologique des cancers.
- C- Se nourrit du stroma tumoral.
- D- Se caractérise par des atypies cyto-nucléaires.
- E- Possède des anomalies intéressant uniquement le noyau.

Source: Q93 P2021

10. La cellule cancéreuse est caractérisée par :

- A- Perte de l'adhésivité intercellulaire.
- B- Perte de l'inhibition de contact.
- C- L'immortalité.
- D- La Transplantabilité.
- E- Une grande sensibilité à l'apoptose.

Source: Q16 P2020

11. La métastase :

- A- Est la propagation de cellules cancéreuses vers des sites et des organes distants du foyer initial.
- B- Est de même nature que la tumeur primitive.
- C- Représente la preuve formelle de la nature maligne d'une tumeur.
- D- Fait la gravité du cancer.
- E- Toujours découverte au moment du diagnostic de la tumeur initiale.

Source: Q23 P2020 & Q22 P2018

12. Une tumeur maligne est une tumeur :

- A- Souvent mal limitée.
- B- Présente un caractère métastatique.
- C- Ne récidive jamais.
- D- Ne comporte pas des mitoses anormales.
- E- A une évolution rapide.

Source: Q28 P2020

13. Toutes ces tumeurs sont des tumeurs malignes sauf une laquelle ;

- A- Lymphome.
- B- Chondrome.
- C- Sarcome d'Ewing.
- D- Carcinome mammaire.
- E- Mélanome.

Source: Q26 P2019 RATRAPAGE

14. Parmi ces critères histologiques de malignité le quel permet de confirmer avec certitude le caractère malin :

- A- Atypies cytonucléaires.
- B- Métastases.
- C- Inflammation.
- D- Fibrose.
- E- Augmentation de la taille des noyaux.

Source: Q31 P2019 RATRAPAGE

15. Anomalie du comportement des cellules cancéreuses :

- A- Perte de l'inhibition de contact.
- B- Perte de l'adhésivité.
- C- Motilité accrue.
- D- Mortalité accrue.
- E- Immortalité.

Source: Q21 P2018

16. Tous les éléments suivants sont considérés comme des changements morphologiques associés à un manque de différenciation ou anaplasie dans tumeur sauf un lequel :

- A- Morphologie nucléaire anormale.
- B- Perte de polarité ou d'orientation des cellules.
- C- Mitose anormale.
- D- Rapport nucléaire / cytoplasme de 1 : 5.
- E- Pléomorphisme.

Source: Q24 P2018

17. Lesquelles des tumeurs suivantes est la moins susceptible de métastaser ?

- A- Carcinome basocellulaire de la peau.
- B- Cholangiocarcinome du foie.
- C- Carcinome endométrial de l'ovaire.
- D- Mélanome du poumon.
- E- Carcinome épidermoïde du larynx.

Source: Q25 P2018

18. Parmi les cancers suivants, lequel est responsable du plus grand pourcentage de décès par cancer chez les hommes chaque année ?

- A- Le cancer du colon / rectum.
- B- La leucémie.
- C- Le cancer du poumon.
- D- Le cancer du pancréas.
- E- Le cancer de la prostate.

Source: Q26 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐

2. Classifications & Diagnostic Tumoral

1. En pathologie tumorale, l'étude Immunohistochimique :

- A- Est toujours effectuée sur la tumeur primitive, jamais sur les métastases.
- B- Permet l'identification d'antigènes cellulaires tumoraux.
- C- Parfois permet de distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes.
- D- Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur.
- E- Peut, dans certains cas, contribuer à prédire la réponse thérapeutique.

Source: Q82 P2022 & Q91 P2021

2. L'examen extemporané :

- A- Permet en général de typer un lymphome.
- B- Se fait en général en faisant des coupes après congélation du tissu.
- C- Est aussi fiable qu'un examen histologique classique.
- D- N'est indiqué que si son résultat modifie un geste opératoire.
- E- Peut être fait sur un tissu calcifié.

Source: Q35 P2020

3. Les techniques immunohistochimiques :

- A- Nécessitent des prélèvements congelés.
- B- Permettent de mettre en évidence des antigènes cellulaires.
- C- Peuvent être utilisées pour préciser le diagnostic d'une tumeur.
- D- Peuvent être utilisées pour préciser le pronostic d'une tumeur.
- E- Peuvent être utilisées pour préciser des indications thérapeutiques.

Source: Q36 P2020

4. Le stade pTNM d'un cancer :

- A- Est établi sur des données anatomopathologiques.
- B- Signifie "Tumeur Non Métastatique".
- C- Traduit le type histologique du cancer.
- D- Traduit l'extension du cancer dans l'organe et l'organisme.
- E- Doit toujours être précisé sur le compte rendu anatomopathologique d'une résection à but curatif d'un cancer.

Source: Q37 P2020

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

3. Carcinogénèse

1. Tous les éléments suivants forment potentiellement la base moléculaire du cancer sauf :

- A- Activation des oncogènes favorisant la croissance.
- B- Activation des gènes suppresseurs de tumeur.
- C- Altération des gènes régulateurs de l'apoptose.
- D- Echec de la réparation de l'ADN.
- E- Mutations dans le génome des cellules somatiques.

Source: Q27 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐

4. Étiologies du cancer

1. Le cancer peut être secondaire à des facteurs génétiques tel que(s)

- A- Le syndrome de Lynch.
- B- La Xeroderma pigmentosum.
- C- La polypose recto colique familiale PAF.
- D- La polypose nasale.
- E- Le cancer du sein lié au gène BRCA1.

Source: Q81 P2022

2. Le cancer peut être secondaire à des facteurs génétiques tel que (s)

- A- Le syndrome de Lynch.
- B- La Xeroderma pigmentosum.
- C- La polypose recto colique familiale PAF.
- D- Le rétinoblastome.
- E- Le cancer du sein lié au gène BRCA1.

Source: Q106 P2021

3. La polypose recto-colique familiale :

- A- Sa transmission est autosomique récessive.
- B- Son évolution spontanée se fait vers la cancérisation.
- C- Le dépistage et l'exérèse des polypes sont la meilleure prévention actuelle du cancer recto-colique.
- D- Caractérisée par le développement de centaines ou de milliers de polypes dans la paroi interne du colon et du rectum.
- E- Risque d'évolution vers un sarcome.

Source: Q1 P2020

4. Quels sont les virus incriminés dans la genèse des cancers humains :

- A- Epstein Barr virus.
- B- Virus de la rage.
- C- Papillomavirus humain.
- D- Virus de la rougeole.
- E- Virus syncytial respiratoire.

Source: Q2 P2020

5. Les mésothéliomes pleuraux sont souvent induits par l'exposition à :

- A- L'amiante.
- B- L'arsenic.
- C- Goudron.
- D- Amines aromatiques et les dérivés azotiques.
- E- Les rayons UV du soleil.

Source: Q3 P2020

6. Le rétinoblastome :

- A- Est une tumeur oculaire de l'enfant.
- B- Est une tumeur bénigne.
- C- Le gène de susceptibilité est le Rb1.
- D- Transmis sur un mode autosomique dominant.
- E- La mutation du gène APC est à l'origine de son apparition.

Source: Q4 P2020

Vous pouvez également trouver les informations de cette question dans le cours

< Tumeurs embryonnaires >

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

5. Progression Tumorale

1. Le cancer in situ est :

- A- Un cancer qui franchit la membrane basale des épithéliums.
- B- Un cancer non invasif.
- C- Un cancer qui peut se développer au niveau des tissus conjonctifs.
- D- Un cancer qui est souvent révélé par le dépistage.
- E- Un cancer qui donne des métastases précoces.

Source: Q12 P2020

2. Quelle est la lésion qui définit le caractère envahissant d'un carcinome malpighien

- A- Anomalies cyto-nucléaires.
- B- Foyers de nécrose.
- C- Rupture de la membrane basale.
- D- Le nombre élevé de mitoses.
- E- Le refoulement des organes de voisinage.

Source: Q16 P2019

3. Le cancer in situ est :

- A- Un cancer non invasif.
- B- Un cancer invasif.
- C- Un cancer qui peut se développer au niveau de tous les tissus de l'organisme.
- D- Un cancer qui peut se développer au niveau des tissus épithéliaux pourvus de membrane basale.
- E- Un cancer qui peut se développer au niveau des tissus épithéliaux dépourvus de membrane basale.

Source: Q24 P2019 RATRAPAGE

III - CANCÉROLOGIE

4. Le carcinome in situ :

- A- Est définie comme étant un cancer intraépithélial ne franchissant pas la membrane basale.
- B- Se voit dans les tissus conjonctifs.
- C- Peut précéder un cancer invasif.
- D- Comporte un potentiel métastatique ganglionnaire très élevé.
- E- Se voit uniquement dans les épithéliums de revêtement.

Source: Q30 P2019 RATRAPAGE

5. L'os est le site métastatique de prédilection de certaines tumeurs : la quelle ou les quelles

- A- Adénocarcinome prostatique.
- B- Carcinome mammaire.
- C- Cancer de la thyroïde.
- D- Carcinome basocellulaire.
- E- Adénocarcinome colique.

Source: Q35 P2019 RATRAPAGE

6. Quelle est la lésion qui définit le caractère envahissant d'un carcinome d'un revêtement malpighien :

- A- Anomalie cytonucléaire.
- B- Foyers de nécrose.
- C- Rupture de la membrane basale.
- D- Nombre élevé de mitoses.
- E- Présence de cellules indifférenciées.

Source: Q7 P2018

7. Un carcinome « in situ » endo-buccal est :

- A- Une atteinte localisée des glandes salivaires accessoires.
- B- Un épithélium intra-épithélial.
- C- Une forme de transition entre épithélium et sarcome.
- D- Un épithélium ne dépassant pas la membrane basale.
- E- Un carcinome adénoïde.

Source: Q12 P2018

8. Les organes ostéophytes sont :

- A- Sein. B- Thyroïde. C- Prostate.
- D- Rein. E- Col utérin.

Source: Q23 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

6. Tumeurs Épithéliales Glandulaires

1. Parmi ces tumeurs glandulaires lesquelles peuvent être bénigne ou malignes ?

- A- Adénocarcinome. B- Carcinome mammaire.
- C- Mélanome. D- Adénome. E- Angiome.

Source: Q87 P2022 & Q96 P2021

ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

2. Une tumeur épithéliale glandulaire maligne est appelée :

- A- Adénome.
- B- Lymphome.
- C- Carcinome épidermoïde.
- D- Sarcome.
- E- Adénocarcinome.

Source: Q29 P2020

3. Tumeurs à différenciation glandulaire :

- A- Sont des tumeurs fréquentes.
- B- Elles sont bénignes : adénome, ou malignes : adénocarcinome.
- C- Elles sont moins fréquentes que les sarcomes.
- D- Leur aspects macroscopiques et histologiques varient selon le type d'organe qu'elles touchent.
- E- Elles intéressent les organes creux les parenchymes glandulaires exocrines et endocrines.

Source: Q19 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

7. Tumeurs Malpighienne & Urothéliales

1. Le carcinome intra-épithélial est :

- A- Considéré comme une dysplasie sévère.
- B- Le diagnostic est le plus souvent clinique.
- C- La membrane basale est envahie.
- D- Considéré comme une lésion précancéreuse.
- E- De bon pronostic.

Source: Q84 P2022

2. Un cancer épidermoïde s'observe fréquemment :

- A- Au niveau du corps utérin.
- B- Au niveau de la peau. C- Au niveau de l'œsophage.
- D- Au niveau des bronches. E- Au niveau du rectum.

Source: Q85 P2022

3. Les condylomes sont

- A- Des Tumeurs bénignes liée à l'HPV.
- B- Le Mode de transmission est sexuel.
- C- Siège souvent au niveau de l'exocol utérin++, vagin, vulve et zone ano-rectale.
- D- Peuvent donner des métastases.
- E- Les condylomes sont parfois multiples.

Source: Q86 P2022

4. Est une tumeur de nature épithéliale :

- A- Mélanome. B- Chondrosarcome.
- C- Carcinome épidermoïde laryngé.
- D- Lymphome. E- Ostéosarcome.

Source: Q85 P2021

5. Parmi les organes suivants pour lequel (lesquels) ; les carcinomes épidermoïdes sont-ils les tumeurs malignes primitives les plus fréquentes :

- A- Le col utérin.
- B- Le colon.
- C- Le pancréas.
- D- Le larynx.
- E- L'œsophage.

Source: Q104 P2021 & Q19 P2019

6. Parmi les tumeurs suivantes, lesquelles concernent le revêtement malpighien

- A- Un carcinome épidermoïde.
- B- Un papillome.
- C- Un adénocarcinome.
- D- Un carcinome baso-cellulaire.
- E- Un leiomyosarcome.

Source: Q105 P2021 & Q17 P2019

7. Les tumeurs épithéliales bénignes peuvent se développer dans :

- A- Peau.
- B- Muqueuses.
- C- Ganglion.
- D- Muscle strié.
- E- Tube digestif.

Source: Q14 P2020

8. Les adénomes colorectaux sont :

- A- Plus fréquents avec l'âge.
- B- Ne sont pas des états précancéreux.
- C- Leur dégénérescence dépend de la taille et du degré de la dysplasie.
- D- Macroscopiquement, ils peuvent être pédiculés ou sessiles.
- E- Ne se cancérisent jamais.

Source: Q15 P2020

9. Ce qui caractérise histologiquement les carcinomes épidermoïdes est :

- A- Des cellules monomorphes.
- B- Des ponts d'union entre les cellules.
- C- La présence de kératine.
- D- Des cellules disposées en palissades.
- E- Un aspect infiltrant.

Source: Q39 P2020

10. Laquelle est une tumeur épithéliale bénigne :

- A- Un adénome.
- B- Un adénocarcinome.
- C- Un angiome.
- D- Un lipome.
- E- Un lymphome.

Source: Q18 P2019

11. Le papillome est :

- A- Une tumeur épithéliale maligne.
- B- Une tumeur épithéliale bénigne.
- C- Souvent dû à une infection par HPV.
- D- Souvent dû à une infection par EBV.
- E- De localisation exclusivement cutanée.

Source: Q20 P2019

12. Le carcinome basocellulaire est une tumeur :

- A- Épithéliale maligne.
- B- Mésenchymateuse maligne.
- C- Donnant des métastases précoces.
- D- Ne donnant pas de métastases.
- E- De localisation cutanée.

Source: Q21 P2019

13. Le condylome est une tumeur :

- A- Qui siège au niveau des muqueuses glandulaires.
- B- Lié à l'infection par HPV.
- C- Qui peut se transformer en un adénocarcinome.
- D- Qui peut se transformer en un carcinome épidermoïde.
- E- Qui peut donner des métastases.

Source: Q22 P2019

14. Parmi les tumeurs suivantes : quelles sont celles qui prennent naissance à partir de l'épithélium malpighien

- A- Carcinome épidermoïde.
- B- Carcinome paramalpighien.
- C- Adénome villeux.
- D- Condylome.
- E- Papillome.

Source: Q25 P2019 RATRAPAGE

15. L'adénocarcinome colique peut être :

- A- Scléronodulaire.
- B- Bien ou moyennement différencié.
- C- Peu différencié ou indifférencié.
- D- Mucineux.
- E- Bague à chaton.

Source: Q29 P2019 RATRAPAGE

16. Un carcinome de type paramalpighien a pour point de départ possible ?

- A- Pancréas.
- B- L'artère.
- C- Le larynx.
- D- Le bassin.
- E- La vessie.

Source: Q6 P2018

17. Parmi les tumeurs ci-dessous , indiquez celle(s) née(s) à partir d'un épithélium pavimenteux ?

- A- Carcinome épidermoïde différencié.
- B- Cystadénocarcinome végétant.
- C- Carcinome malpighien immature.
- D- Carcinome transitionnel excréto-urinaire.
- E- Adénocarcinome.

Source: Q8 P2018

18. Un cancer épidermoïde s'observe fréquemment

- A- Au niveau du corps utérin.
- B- Au niveau de la peau.
- C- Au niveau de l'œsophage.
- D- Au niveau de l'estomac.
- E- Au niveau du rectum.

Source: Q9 P2018

19. Sont des tumeurs épithéliales :

- A- Les condylomes.
- B- Les léiomyomes.
- C- Les papillomes.
- D- Les lipomes.
- E- Les adénomes.

Source: Q11 P2018

20. Les exemples des structures épithéliales :

- A- Peau.
- B- Muqueuse.
- C- Ganglion.
- D- Vessie.
- E- Tube digestif.

Source: Q20 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐

8. Tumeurs Mésenchymateuse**1. Parmi ces tumeurs lesquelles sont d'origine mésenchymateuse ?**

- A- Hémangiome.
- B- Liposarcome.
- C- Lymphome malin hodgkinien.
- D- Naevus dermique.
- E- Carcinome urothélial.

Source: Q91 P2022 & Q88 P2021

En 2021, la même question avec la même correction, mais la proposition D a été changée en D- Adénocarcinome.

2. Un léiomyome est

- A- Une tumeur conjonctive bien limitée.
- B- Une tumeur musculaire lisse.
- C- Un fibrome.
- D- Une tumeur maligne.
- E- Siège exclusivement au niveau de l'utérus.

Source: Q92 P2022

3. Un léiomyosarcome

- A- Est une tumeur maligne germinale.
- B- Est une tumeur maligne mésenchymateuse.
- C- Est une tumeur maligne épithéliale.
- D- Prend naissance à partir des cellules musculaires lisses.
- E- Prend naissance à partir des cellules musculaires striées.

Source: Q93 P2022

4. Parmi ces tumeurs les quelles sont des tumeurs conjonctives

- A- Adénome.
- B- Lipome.
- C- Rhabdomyosarcome.
- D- Fibromatose.
- E- Lymphome.

Source: Q94 P2022

5. Parmi ces tumeurs, laquelle ou lesquelles sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes :

- A- Leiomyome.
- B- Rhabdomyosarcome.
- C- Mélanome.
- D- Lipome.
- E- Adénome.

Source: Q27 P2020

6. Le léiomyosarcome :

- A- Est une tumeur épithéliale maligne.
- B- Ne comporte pas d'anomalies cyto-nucléaires.
- C- Constituées de fibres musculaires lisses.
- D- Est une tumeur conjonctive maligne constituée de fibres musculaires striée.
- E- Ne donne jamais de métastase.

Source: Q1 P2019 RATRAPAGE

7. Le chondrome :

- A- Tumeur bénigne épithéliale constituée de chondrocytes.
- B- Tumeur conjonctive bénigne à différenciation cartilagineuse.
- C- Est constitué de plages de tissu osseux.
- D- Parfois il donne de métastase.
- E- Il récidive après exérèse chirurgicale complète.

Source: Q2 P2019 RATRAPAGE

8. Parmi ces tumeurs les quelles sont des tumeurs mésenchymateuses (conjonctives) :

- A- Lipome.
- B- Léiomyome.
- C- Ostéome.
- D- Lymphome.
- E- Mélanome.

Source: Q34 P2019 RATRAPAGE

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

9. Lymphomes

1. Les lymphomes peuvent être :

- A- De phénotype A.
B- De phénotype B. C- De phénotype T.
D- A grandes cellules. E- A petites cellules.

Source: Q95 P2022 & Q94 P2021

2. Lesquelles parmi ces propositions sont d'origine hématologique :

- A- Angiome. B- Lymphome à grandes cellules.
C- Lymphome de Hodgkin. D- Léomyome.
E- Lymphome de Burkitt.

Source: Q95 P2021

3. Laquelle des tumeurs malignes de l'enfance suivantes est la tumeur la plus fréquente chez les enfants moins de 10 ans :

- A- Glioblastome.
B- Carcinome hépatocellulaire sur foie cirrhotique.
C- Leucémie. D- Adénocarcinome colique.
E- Rhabdomyosarcome.

Source: Q30 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

10. Tumeurs Nerveuses et Mélanocytaires

1. Le naevus naevocellulaire :

- A- On distingue le naevus congénital et le naevus acquis.
B- Apparait pour la plupart à partir de 60 ans.
C- Est une lésion pigmentée unique ou multiple.
D- Microscopiquement ; il s'agit d'une prolifération de cellules naevique groupées en thèques.
E- Les atypies et les mitoses sont fréquentes.

Source: Q88 P2022

2. Le schwannome :

- A- Est une prolifération bénigne des cellules de Schwann de la gaine des nerfs.
B- Est fréquent au cours de la neurofibromatose de type 1.
C- Peut dégénérer en schwannome malin.
D- Comportant des zones cellulaires (ANTONI A), nodule de Verocay et des zones lâches (ANTONI B).
E- Est une tumeur du système nerveux central.

Source: Q89 P2022

3. Le neurofibrome :

- A- Est une tumeur maligne.
B- Peut être sporadique ou multiple compliquant la maladie de RECKLINGHAUSEN.
C- Est une prolifération de cellules fibroblastiques dissociant les nerfs.
D- Les atypies et les mitoses sont fréquentes.
E- Est une tumeur nerveuse périphérique.

Source: Q90 P2022

4. Parmi les éléments cellulaires suivants, lequel (lesquels) constitue(nt) les cellules nevrogliques du tissu nerveux central :

- A- L'Astrocyste.
B- L'Oligodendrocyte. C- La Cellule épendymaire.
D- Le Thyrocyte. E- Le Thymocyte.

Source: Q17 P2020

5. Concernant la démarche diagnostique des tumeurs nerveuses, tous ces examens sont indispensables sauf un, lequel :

- A- La TDM cérébrale.
B- La radiographie standard du crâne.
C- L'IRM cérébrale.
D- Tomographie par émission de positons (PET-Scan).
E- Biopsie.

Source: Q18 P2020

6. Parmi les tumeurs nerveuses ci-dessous, indiquez celle(s) qui apparten(en)t aux tumeurs gliales :

- A- Médulloblastome.
B- Tumeurs du plexus choroïde.
C- Glioblastome.
D- Oligodendrogliome anaplasique.
E- Épendymome.

Source: Q19 P2020

7. Le grading des tumeurs nerveuses est basé sur :

- A- L'hémorragie.
B- L'infiltrat inflammatoire.
C- La prolifération vasculaire endothélio-capillaire.
D- La nécrose.
E- La densité cellulaire.

Source: Q20 P2020

8. Concernant les méningiomes :

- A- Ce sont des tumeurs de croissance lente, développées à partir des cellules méningothéliales de l'arachnoïde.
B- Elles concernent le plus souvent les enfants, à prédominance masculine.
C- Elles concernent le plus souvent les femmes à partir de 60 ans.
D- L'OMS a défini trois grades histologiques selon leur agressivité.
E- Les facteurs hormonaux progestéroniques ont un rôle protecteur.

Source: Q21 P2020

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

11. Tumeurs Embryonnaires

1. Les tumeurs embryonnaires sont caractérisées par :

- A- Une origine à partir de cellules indifférenciées.
- B- Une prédominance chez les enfants.
- C- Une possibilité d'atteindre les adultes.
- D- Une absence totale de malignité.
- E- Une localisation exclusivement testiculaire.

Source: Q96 P2022

2. Les tumeurs germinales peuvent être :

- A- Séminomes.
- B- Non-séminomateuses.
- C- Localisées dans les testicules ou les ovaires.
- D- Toujours bénignes.
- E- Extra-gonadiques (médiastin, cerveau).

Source: Q97 P2022

3. Les tératomes sont des tumeurs qui :

- A- Peuvent contenir des tissus issus des trois feuillets embryonnaires.
- B- Peuvent être matures ou immatures.
- C- Sont souvent bénins lorsqu'ils sont matures.
- D- Sont exclusivement testiculaires.
- E- Sont uniquement constitués de tissus nerveux.

Source: Q98 P2022

4. Les marqueurs tumoraux associés aux tumeurs germinales incluent :

- A- Alpha-foetoprotéine (AFP).
- B- Bêta-HCG.
- C- Phosphatase alcaline placentaire (PLAP).
- D- Myoglobine.
- E- Hémoglobine.

Source: Q99 P2022

5. Le néphroblastome (tumeur de Wilms) :

- A- Touche principalement l'enfant.
- B- Se développe au niveau du rein.
- C- Peut être associé à une anomalie génétique.
- D- Est toujours bilatéral.
- E- Est principalement constitué de tissu osseux.

Source: Q100 P2022

6. Les tumeurs germinales

- A- Siègent uniquement au niveau des gonades.
- B- Sont des tumeurs rares.
- C- Malignes ; elles sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme.
- D- Elles se développent à partir des cellules germinales primordiales.
- E- Leur différenciation morphologique est variée, reproduisant des structures observables au cours de l'embryogenèse.

Source: Q97 P2021

7. Seminome

- A- Egalement appelé dysgerminome au niveau de l'ovaire.
- B- Tumeur germinale présentant une similitude morphologique avec les gonies.
- C- Le pic de fréquence vers 30 ans.
- D- Tumeur germinale la moins fréquente du testicule.
- E- Le traitement est basé sur la chirurgie et la radiothérapie rarement la chimiothérapie.

Source: Q98 P2021

8. Les tératomes matures

- A- Sont des tumeurs germinales avec une différenciation somatique.
- B- Très fréquentes au niveau de l'ovaire.
- C- Sont des tumeurs malignes.
- D- Souvent appelé « kyste dermoïde ».
- E- Peuvent être simples ou complexes pluritissulaires.

Source: Q99 P2021

9. Les tumeurs du blastème embryonnaire

- A- Apparaissent souvent dans l'enfance.
- B- Leur pronostic dépend de l'âge et du stade de la maladie.
- C- Parfois deviennent « matures » spontanément ou sous l'effet de la chimiothérapie.
- D- A l'histologie, les zones blastémateuse indifférenciées sont faites de nappes de petites cellules rondes et bleues.
- E- Sont bénignes avec une évolution lente.

Source: Q100 P2021

10. Le rétinoblastome

- A- Est une tumeur uniquement héréditaire.
- B- Le gène de la mutation génétique est le RB1.
- C- Il s'agit d'une tumeur à petites cellules rondes et bleues de type neuroectodermique.
- D- Le traitement est l'énucléation du globe oculaire, associée à la chimiothérapie ou la radiothérapie selon le bilan d'extension.
- E- Se développe au niveau de la rétine.

Source: Q101 P2021

11. On a récemment diagnostiqué chez une fillette de 6 ans un neuroblastome surrénalien ; on teste quel gène pour une preuve d'amplification ? La RJ

- A- C- MYC. B- K- RAS. C- L- MYC.
- D- N- MYC. E- N- RAS.

Source: Q28 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐

RÉPONSES

1. Tumeurs & Processus Tumorale

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☐	☒	☒
Q3	☒	☒	☒	☒	☐
Q4	☐	☒	☒	☒	☒
Q5	☒	☒	☒	☐	☐
Q6	☒	☒	☐	☒	☐
Q7	☒	☒	☐	☒	☒
Q8	☒	☐	☒	☒	☒
Q9	☒	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q10	☒	☒	☒	☒	☐
Q11	☒	☒	☒	☒	☐
Q12	☒	☒	☐	☐	☒
Q13	☐	☒	☐	☐	☐
Q14	☐	☒	☐	☐	☐
Q15	☒	☒	☒	☐	☒
Q16	☐	☐	☐	☒	☐
Q17	☒	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☒	☐	☐

2. Classifications & Diagnostic Tumoral

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☒	☒
Q2	☐	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☒	☒	☒	☒
Q4	☒	☐	☐	☒	☒

3. Carcinogénèse

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☐	☐

4. Étiologies du cancer

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☒	☒	☒	☒
Q3	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☒	☐	☒	☐	☐
Q5	☒	☐	☐	☐	☐
Q6	☒	☐	☒	☒	☐

5. Progression Tumorale

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☒	☐
Q2	☐	☐	☒	☐	☐
Q3	☒	☐	☐	☒	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q5	☒	☒	☒	☐	☐
Q6	☐	☐	☒	☐	☐
Q7	☐	☒	☐	☒	☐
Q8	☒	☒	☒	☒	☐

6. Tumeurs Épithéliales Glandulaires

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☒	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☐	☒	☒

7. Tumeurs Malpighienne & Urothéliales

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☒	☒
Q2	☐	☒	☒	☒	☐
Q3	☒	☒	☒	☐	☒
Q4	☐	☐	☒	☐	☐
Q5	☒	☐	☐	☒	☒
Q6	☒	☒	☐	☒	☐
Q7	☒	☒	☐	☐	☒
Q8	☒	☐	☒	☒	☐
Q9	☐	☒	☒	☐	☒
Q10	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q11	☐	☒	☒	☐	☐
Q12	☒	☐	☐	☒	☒
Q13	☐	☒	☐	☒	☐
Q14	☒	☐	☐	☒	☒
Q15	☒	☒	☒	☒	☒
Q16	☐	☒	☐	☒	☒
Q17	☒	☐	☒	☐	☐
Q18	☐	☒	☒	☐	☐
Q19	☒	☐	☒	☐	☐
Q20	☒	☒	☐	☒	☒

8. Tumeurs Mésenchymateuse

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☐	☐
Q2	☒	☒	☐	☐	☐
Q3	☐	☒	☐	☒	☐
Q4	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q5	☒	☐	☐	☒	☐
Q6	☐	☐	☒	☐	☐
Q7	☐	☒	☐	☐	☐
Q8	☒	☒	☒	☐	☐

9. Lymphomes

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☒	☒
Q2	☐	☒	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☒	☐	☐

10. Tumeurs Nerveuses et Mélanocytaires

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☒	☒	☐
Q2	☒	☐	☒	☒	☐
Q3	☐	☒	☒	☐	☒
Q4	☒	☒	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q5	☐	☒	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☒	☒	☐
Q7	☐	☐	☒	☒	☒
Q8	☒	☐	☒	☒	☒

11. Tumeurs Embryonnaires

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☒	☐	☐
Q4	☒	☒	☒	☐	☐
Q5	☒	☒	☒	☐	☐
Q6	☐	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q7	☒	☒	☒	☐	☒
Q8	☒	☒	☐	☒	☒
Q9	☒	☒	☒	☒	☐
Q10	☐	☒	☒	☒	☒
Q11	☐	☐	☐	☒	☐

CAS CLINIQUES

Cas Clinique I

○ Un enfant de 4 ans, sexe féminin se présente aux urgences pédiatriques pour une douleur abdominale avec HTA chiffrée à 15/9, associée à une hématurie ++, sans signes généraux.

○ Une échographie abdominale a été faite objectivant une masse abdominale solitaire de 10 cm de grand axe d'appartenance rénale.

1. Quel examen radiologique de référence permettant de mieux apprécier les caractéristiques de cette masse ainsi son origine ?

masse ainsi son origine.

- A- Une TDM thoracique.
- B- Une TDM cérébrale.
- C- Une coloscopie.
- D- Une TDM abdominale.
- E- Téléthorax.

Source: Q107 P2021

○ Les données radiologiques ont montré qu'il s'agit d'une masse rénale droite.

2. Quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant de 4 ans :

- A- Néphroblastome ou tumeur de Wilms.
- B- Adénocarcinome colique.
- C- Tumeur cérébrale.
- D- Médulloblastome.
- E- Retinoblastome.

Source: Q108 P2021

3. Sur le plan microscopique, cette tumeur se compose de :

- A- Cellules fusiformes musculaires lisses.
- B- De trois composants : épithélial, blastémateux et stromal.
- C- Uniquement de structures glandulaires.
- D- D'un parenchyme rénal inflammatoire.
- E- De lobules carcinomateux de cellules malpighiennes.

Source: Q109 P2021

4. Quelle est la meilleure conduite thérapeutique à suivre pour cette tumeur maligne :

- A- Traitement symptomatique avec surveillance.
- B- Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie.
- C- Traitement chirurgical seul.
- D- Abstention thérapeutique.
- E- Néphrectomie bilatérale.

Source: Q110 P2021

Cas Clinique II

○ Il s'agit d'un enfant âgé de 7 ans, de sexe masculin, aux antécédents de céphalées intermittentes admis aux urgences pour des céphalées intenses, vertige, des vomissements en jet et des troubles visuels, absence de fièvre ou de syndrome infectieux.

○ Une IRM cérébrale a été faite en urgence et a retrouvé une masse solide hétérogène en hyposignal, au niveau de la fosse cérébrale postérieure, mal limitée et infiltrante les structures adjacentes. Absence de dissémination méningée.

○ Le patient a été admis au bloc opératoire en urgence, une résection partielle de la masse a été faite et les prélèvements sont adressés pour l'étude anatomopathologique.

5. Quel est le signe clinique redoutable nécessitant une intervention chirurgicale en urgence pour soulager le malade ?

- A- Céphalées intenses.
- B- Hypertension intracranienne.
- C- Trouble de la marche.
- D- Perte de conscience.
- E- Altération de la vision.

Source: Q46 P2020

6. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A- Un méningiome.
- B- Carcinome du plexus choroïde.
- C- Neurofibrome.
- D- Médulloblastome.
- E- Néphroblastome.

Source: Q47 P2020

7. Une étude anatomopathologique est effectuée. Quel(s) est(sont) le(s) critère(s) microscopique(s) que vous attendez ?

- A- Prolifération néoplasique maligne épithéliale faite de structures glandulaires.
- B- Refoule sans infiltrer le tissu avoisinant.
- C- Prolifération neuroépithéliale embryonnaire de cellules rondes indifférenciées.
- D- Les figures mitotiques sont rares.
- E- Présence de rosettes.

Source: Q48 P2020

8. Quelle(s) est(sont) le(s) arme(s) thérapeutique(s) ?

- A- Chirurgie.
- B- Chimiothérapie.
- C- Radiothérapie.
- D- Hormonothérapie.
- E- Abstention thérapeutique.

Source: Q49 P2020

9. Récemment, de nouvelles technologies ont permis d'introduire des sous-types génétiques de cette tumeur pour une meilleure prise en charge thérapeutique, la ou lesquelles ?

- A- La biologie moléculaire.
- B- La culture cellulaire.
- C- L'immunohistochimie.
- D- L'histochimie.
- E- L'immunofluorescence directe.

Source: Q50 P2020

Cas Clinique III

○ Ils'agit d'une femme âgée de 32 ans, présente depuis 1 an une formation 1 à 2 cm au niveau du sein droit (quadrant supéro-externe) qu'elle a découvert à l'autopalpation.

○ A l'occasion d'une consultation gynécologique pour son frottis de dépistage, elle le signale à sa gynécologue. il n'existe aucun antécédent cancer familial. Le frottis cervico-vaginal de dépistage est revenu normal sans anomalies cytologiques.

○ L'échographie et la mammographie confirment une masse nodulaire mammaire bien limitée de 2 cm . située au quadrant supéro-externe du sein droit.

○ Une biopsie mammaire guidée par l'échographie montre à l'examen anatomo-pathologique des carottes biopsiques qui ont intéressé une prolifération tumorale à double composante :

- d'une part, épithéliale agencée en structures glandulaires étirées;

- d'autre part, conjonctive riche en collagène avec fibroblastes.

- Absence de critères cytologiques de malignité.

10. Quel est votre diagnostic :

A- Carcinome mammaire non spécifique.

B- Carcinome mammaire lobulaire infiltrant.

C- Adénofibrome mammaire.

D- Sarcome phyllode.

E- Angiosarcome mammaire.

Source: Q36 P2019

11. Une tumorectomie est effectuée. Quel (s) est (sont) le (s) critère (s) (macroscopiques, microscopiques) que vous attendez :

A- Tumeur mal limitée (limites spiculées).

B- Tumeur encapsulée.

C- Refoule sans détruire le tissu avoisinant.

D- Histologiquement semblable au tissu mammaire à l'origine de cette tumeur.

E- Présence d'embolies vasculaires lymphatiques et veineux.

Source: Q37 P2019

12. Quels sont les risques locaux, à distance et évolutif de cette tumeur:

A- Absence de récurrence locale après exérèse complète.

B- Il existe un risque métastatique au niveau du poumon.

C- La patiente est déclarée guérie après exérèse complète.

D- Il existe un risque de récurrence locale si l'exérèse est incomplète.

E- Il existe un risque métastatique au niveau des ganglions lymphatiques du creux axillaire du sein droit.

Source: Q38 P2019

○ Au cours du long suivi gynécologique de cette patiente qui a eu plusieurs partenaires sexuels au cours de sa vie et à l'âge de 60 ans un frottis de dépistage montre la présence de cellules malpighiennes atypiques avec présence de Koïlocytes.

13. Quel est l'agent pathogène responsable de ces anomalies cytologiques des cellules malpighienne et de ces cellules Koïlocytaires :

A- Le mycobacterium tuberculosis.

B- Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine).

C- L'EBV (Epstein barr virus).

D- L'HPV (human papillomavirus).

E- L'Herpès simplex virus.

Source: Q39 P2019

14. Une biopsie sous colposcopie suivie d'une conisation du col utérin montre une jonction exo-endocervicale siège d'anomalies cytologiques architecturales, et des modifications cytologiques touchant les cellules malpighiennes.

○ Ces anomalies cytologiques sont limitées à l'épithélium de surface (sur toute sa hauteur) avec la présence de Koïlocytes.

La membrane basale est respectée, Il n'existe pas d'envahissement tumoral du chorion sous-jacent :

A- Il s'agit d'un carcinome malpighien in situ ou d'une dysplasie malpighienne de haut grade.

B- Il s'agit d'un adénocarcinome in situ.

C- Il s'agit d'un carcinome malpighien invasif du col utérin.

D- Il s'agit d'un adénocarcinome invasif du col utérin.

E- Il existe actuellement un risque métastatique au niveau des ganglions lymphatiques régionaux.

Source: Q40 P2019

Cas Clinique IV

- Il s'agit d'une femme âgée de 58 ans, qui présente un nodule dans le quadrant supéro-externe du sein gauche, découvert lors d'un bilan sénologique de dépistage (mammographie)
- La biopsie de ce nodule confirme son caractère malin et la patiente bénéficie d'un traitement chirurgical de type tumorectomie + curage ganglionnaire axillaire .
- La pièce de tumorectomie est adressée au laboratoire d'anatomie-pathologique pour examen extemporané.

15. Qu'est-ce qu'un examen extemporané et quelle est son utilité dans ce cas :

- A- C'est un examen réalisé en peropératoire.
- B- Permet de s'assurer de l'exérèse de la totalité de la lésion avec des marges suffisantes.
- C- Le prélèvement envoyé doit être fixé au formol.
- D- Les coupes sont réalisées sur prélèvement de tissu frais congelé à -30°C.
- E- Permet de guider l'acte chirurgical.

Source: Q37 P2019 RATRAPAGE

- Un examen macroscopique est ensuite réalisé. Des prélèvements sont réalisés sur la tumeur mammaire, sur les limites de résection et sur tous les ganglions du curage axillaire.

16. Quel est le type histologique malin épithélial le plus attendu lors de cet examen :

- A- Carcinome mammaire.
- B- Adénofibrome mammaire.
- C- Dystrophie fibrokystique.
- D- Lymphome.
- E- Mélanome malin primitif mammaire.

Source: Q38 P2019 RATRAPAGE

17. Parmi ces cancers gynécologiques lequel est le plus fréquent chez la femme algérienne :

- A- Le cancer de l'ovaire.
- B- Le cancer du col utérin.
- C- Le cancer de l'endomètre.
- D- Le cancer du sein.
- E- Le cancer du vagin.

Source: Q39 P2019 RATRAPAGE

18. Quel est le moyen de dépistage du cancer du col utérin :

- A- L'échographie pelvienne.
- B- L'IRM pelvienne.
- C- Hystéroscopie.
- D- Le FCV : frottis cervico-vaginal.
- E- La TDM pelvienne.

Source: Q40 P2019 RATRAPAGE

Cas Clinique V

19. Cette tumeur a été découverte chez un garçon de 7 ans ; une mutation dans lequel des gènes suivants est responsable de la production de ce néoplasme ? (figure 01)

Figure 01:



Image Macroscopique

Image Microscopique

- A- NF- 1.
- B- NF- 2.
- C- P53.
- D- PTEN.
- E- RB.

Source: Q29 P2018

Cas Clinique VI

- Une femme de 43ans a noté des menstruations exceptionnellement abondantes d'une durée de 6 à 8 jours ,pendant 4mois ,

- Elle a également noté des saignement inter menstruels mineurs.

- A l'examen physique, son col utérin semble normal et un frottis cervico-utérin ne montre aucune cellule anormale.

- L'examen pelvien révèle que l'utérus est agrandi à deux fois la taille normale et est nodulaire (plusieurs formations nodulaires de taille différentes situées pour la plupart dans le myomètre bien limitées rondes à ovales)

- Il n'y a pas de masses annexielles

20. lequel des énonces suivants est le diagnostic le plus probable ?

- A- Un carcinome de l'endomètre.
- B- Multiples léiomyomes.
- C- Grossesse extra-utérine.
- D- Endométriose.
- E- Syphilis secondaire.

Source: Q31 P2018

Cas Clinique VII

- Une femme sexuellement active de 28 ans subit un examen de routine.
 - L'examen pelvien ne révèle aucune anomalie.
 - Un frottis cervico-utérin est obtenu, le rapport de la cytopathologie indique la présence de cellules sévèrement dysplasiques (lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade ou HSIL).
 - Une biopsie du col de l'utérus est réalisée et à l'examen microscopique on note une néoplasie intra-épithéliale cervicale de grade III (CIN III).

21. L'infection par lequel des organismes suivants est le plus susceptible de provoquer sa maladie ?

- A- Une infection par le virus Herpes simplex.
 B- Virus D' Epstein Barr. C- Candida albicans.
 D- Papillomavirus humain. E- Trichomonas vaginalis.

Source: Q32 P2018

Cas Clinique VIII

- Une femme de 40 ans souffre d'inconfort pelvien depuis plus d'un mois, ainsi que d'une perte de poids de 4Kg et de nervosité.
 - Un examen pelvien révèle une grande masse annexielle gauche qui à l'échographie transvaginale se présente sous forme d'une masse kystique et solide de 10 cm l'utérus semble de taille normale.
 - Un frottis cervico-utérin est normal, la masse est retirée et lors d'un examen pathologique macroscopique, elle est remplie de cheveux et de sébum, ainsi que des zones bronzées et solides à coté de la paroi externe à surface lisse. A l'examen microscopique on note : (figure2)
 - des tissus matures de type malpighien - ainsi que des follicules pilo-sébacés,
 - des glandes bronchiques de morphologie normale, - un tissu thyroïdien mature
 - un tissu cartilagineux mature

22. lequel des diagnostics suivants correspond à la pathologie de cette femme : La RJ

- A- Tératome pluritissulaire mature.
 B- Choriocarcinome. C- Cystadénome séreux.
 D- Dysgerminome. E- Tératome pluritissulaire immature.

Source: Q33 P2018

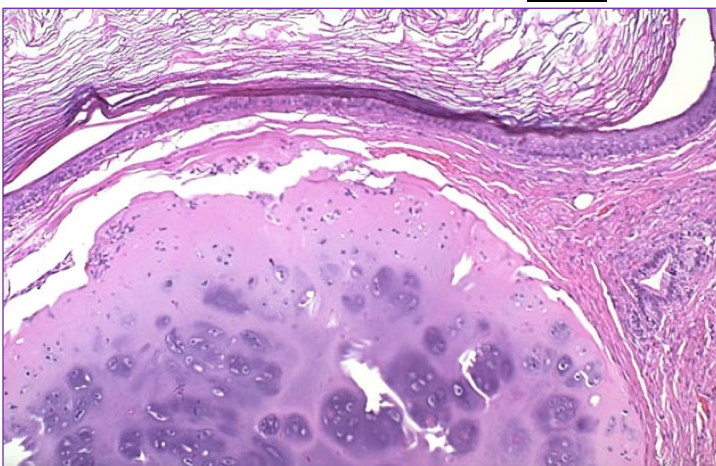


Figure 02

Cas Clinique IX

- Un homme de 24 ans est victime d'un accident routier suite à une collision de son véhicule et subit une fracture du fémur gauche pendant son séjour à l'hôpital, 2 jours après l'accident il est dyspnéique et désorienté et il développe des pétéchie sur son tronc et au niveau de l'aisselle.

23. Quel est le diagnostic le plus probable ? La RJ

- A- Embolie graisseuse.
 B- Thromboembolie pulmonaire.
 C- Embolie septique.
 D- Embolie gazeuse.
 E- Embolie bactérienne.

Source: Q40 P2018

Cas Clinique X

- Il s'agit d'une femme âgée de 32 ans se connaît depuis 1 an une formation 1 à 2 cm au niveau du sein droit (quadrant supéro-externe) qu'elle a découvert à l'autopalpation, à l'occasion d'une consultation gynécologique pour son frottis de dépistage elle le signale à sa gynécologue.
- Il n'existe aucun antécédent du cancer familial ; le frottis cervico-vaginale de dépistage est revenu normal sans anomalies cytologique.
- L'échographie et la mammographie confirment une masse nodulaire mammaire bien limitée de 2 cm située au quadrant supéro-externe du sein droit.
- Une biopsie mammaire guidée par l'échographie montre à l'examen anatomo-pathologique des crottes biopsique qui ont intéressé une prolifération tumorale à double composante :

- d'une part, épithéliale agencée en structures glandulaires étirées ;
- d'autre part, conjonctive riche en collagène avec fibroblaste, absence de critères cytologiques de malignité ;

24. Quel est votre diagnostic : la RJ

- A- Carcinome mammaire non spécifique.
 B- Carcinome mammaire lobulaire infiltrant.
 C- Adénofibrome mammaire.
 D- Sarcome phyllode.
 E- Angiosarcome mammaire.

Source: Q41 P2018

25. Une tumorectomie est effectuée , quel(s) est (sont) le(s) critère(s) (macroscopique,microscopique) que vous attendez :

- A- A. tumeur mal limitée (limites spéculées).
- B- B. Tumeur encapsulée.
- C- C. Refoule sans détruire le tissu avoisinant.
- D- D. Histologiquement semblable au tissu mammaire à l'origine de cette tumeur.
- E- Présence d'embolies vasculaires lymphatiques et veineux.

Source: Q42 P2018

26. Quels sont les risques locaux, à distance et évolutif de cette tumeur :

- A- Absence de récurrence locale après exérèse complète.
- B- Il existe un risque métastatique au niveau du poumon.
- C- La patiente est déclarée guérie après exérèse complète.
- D- Il existe un risque de récurrence locale si l'exérèse est incomplète.
- E- Il existe un risque métastatique au niveau des ganglions lymphatiques du creux axillaire du sein droit.

Source: Q43 P2018

○ Au cours du long suivi gynécologique de cette patiente qui a eu plusieurs partenaires sexuels au cours de sa vie et à l'âge de 60 ans un frottis de dépistage montre la présence de cellules malpighiennes atypiques avec la présence de koilocytes ;

27. Quel est l'agent pathogène responsable de ces anomalies cytologiques des cellules malpighiennes et de ces cellules koilocytaires :

- A- Le mycobactérienne tuberculosis.
- B- Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine).
- C- L'EBV (epstein barr virus).
- D- L'HBV (human papilloma virus).
- E- L'herpès simplex virus.

Source: Q44 P2018

○ Une biopsie sous colposcopie suivie d'une conisation du col utérin montre une jonction exo-endocavitaire siège d'anomalies cytologiques architecturales et des modifications cytologiques touchant les cellules malpighiennes

○ Ces anomalies cytologiques sont limitées à l'épithélium de surface (sur toute sa hauteur) avec la présence de koilocytes la membrane basale est respectée ,

○ Il n'existe pas d'envahissement tumoral du chorion sous jacent (figure 3)

28. parmi ces propositions laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

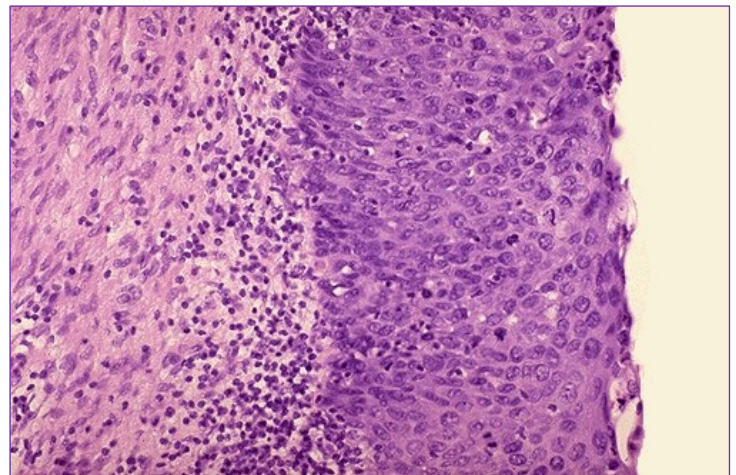


Figure 03

A- Il s'agit d'un carcinome malpighien in situ ou d'une dysplasie malpighienne de haut grade.

B- Il s'agit d'un adénocarcinome in situ.

C- Il s'agit d'un carcinome malpighien invasif du col utérin.

D- Il s'agit d'un adénocarcinome invasif du col utérin.

E- Il existe actuellement un risque métastatique au niveau des ganglions lymphatiques régionaux.

Source: Q45 P2018

Cas Clinique XI

○ Il s'agit d'une femme âgée de 58 ans qui présente un nodule dans le quadrant supéro-externe du sein gauche découvert lors d'un bilan sénologique de dépistage (mammographie).

○ La biopsie de ce nodule confirme son caractère malin et la patiente bénéficie d'un traitement chirurgical de type tumorectomie + curage ganglionnaire axillaire.

○ La pièce de tumorectomie est adressée au laboratoire d'anatomo-pathologie pour examen extemporané ;

29. Qu'est qu'un examen extemporané et quelle est son utilité dans ce cas ?

A- C'est un examen réalisé au cours d'une intervention chirurgicale dont le résultat rapidement transmis au chirurgien est susceptible de modifier l'attitude chirurgicale.

B- Permet de s'assurer de l'exérèse de la totalité de la lésion avec des marges suffisantes.

C- L'exérèse chirurgicale doit être complétée si les marges chirurgicales sont insuffisantes.

D- Le prélèvement reçu doit être immédiatement fixé au formol tamponné à 10% pour réaliser cet examen extemporané.

E- Les coupes sont réalisées sur prélèvement de tissu frais dans un cryostat à -30°C.

Source: Q46 P2018

○ Un examen macroscopique est ensuite réalisé, des prélèvements sont réalisés sur la tumeur mammaire sur les limites de résection et sur tout les ganglions du curage axillaire ;

30. Quel est le type histologique le plus entendu lors de l'examen microscopique des prélèvements réalisés ?

A- Carcinome mammaire.

B- Adénofibrome mammaire.

C- Sarcome phyllode.

D- Angiosarcome mammaire.

E- Mélanome malin primitif mammaire.

Source: Q47 P2018

31. Par quel procédé technique recherche-t-on l'expression des récepteurs hormonaux pour ce cancer mammaire :

A- Etude histologique après coloration standard à l'hématoxyline éosine.

B- Coloration spéciale au rouge congo.

C- Etude immunohistochimique.

D- Coloration spéciale au bleu de toluidine.

E- Coloration spéciale au MGG.

Source: Q48 P2018

RÉPONSES

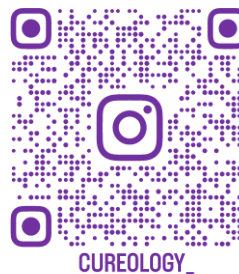
Cas Cliniques

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☒	☐	☐	☐
Q4	☐	☒	☐	☐	☐
Q5	☐	☒	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☒	☐
Q7	☐	☐	☒	☐	☒
Q8	☒	☒	☐	☒	☐
Q9	☒	☐	☒	☐	☐
Q10	☐	☐	☒	☐	☐
Q11	☐	☒	☒	☒	☐
Q12	☒	☐	☒	☒	☐
Q13	☐	☐	☐	☒	☐
Q14	☒	☐	☐	☐	☐
Q15	☒	☒	☐	☐	☒
Q16	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q17	☐	☐	☐	☒	☐
Q18	☐	☐	☐	☒	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☒
Q20	☐	☒	☐	☐	☐
Q21	☐	☐	☐	☒	☐
Q22	☒	☐	☐	☐	☐
Q23	☒	☐	☐	☐	☐
Q24	☐	☐	☒	☐	☐
Q25	☐	☒	☒	☒	☐
Q26	☒	☐	☒	☒	☐
Q27	☐	☐	☐	☒	☐
Q28	☒	☐	☐	☐	☐
Q29	☒	☒	☒	☐	☒
Q30	☒	☐	☐	☐	☐
Q31	☐	☐	☒	☐	☐

-FIN-

Merci pour votre confiance en la série



Restons en contact !

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةُ عَرْشِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ